Manejo integral de patologías respiratorias en la gestante: a propósito de un caso clínico

Servicio de Ginecología y UCI
Médicas internas
Juana Maria Gonzalez
Angie Melisa Ruiz
Residentes de Medicina Familiar
Sharon Katherine Acuña - Ginecóloga y Obstetra / Líder

Caso x presentado 7/9/2025 - 12/9/2025
JLTC 1007307547



Se trata de paciente de 27 años G2P1V1 quien ingresa al servicio de urgencias el 7/9/2025 con gestación de 31+3 semanas, con antecedente de asma no tratado por cuadro clínico 1 día de evolución consistente en disnea de pequeños esfuerzo asociado a disfagia tos cianosante emetizante sin movilización de secreciones con antecedente de asma, en manejo con bromuro de ipratropio y betametasona sin mejoría de su cuadro

VARIABLES EPIDEMIOLÓGICAS

- Nacionalidad:colombiana
- estrato socioeconómico: 1
- EAPB coosalud regimen: subsidiado
- Residencia: vereda pueblo viejo - moniquira
- Estado civil: unión libre
- Escolaridad: bachiller
- vivía con: madre, hija de 10 meses y esposo en vereda - puente nacional
- Empleo : agricultura / galpones
- Circulo social: familia -manifestó durante todo su historial médico tener una buena red de apoyo
- Alimentación rica en carbohidratos
- Tenía dos gatos desde hace 5 años
- **prevención y promoción** vacunación:
- covid #1 dosis: astrazeneca previo a gestacion
- tétano en embarazo anterior: si *

ANTECEDENTES

- Patológicos: **asma, palpitaciones taquicardia sinusal pregestacional**
- Quirúrgicos: niega
- Farmacológicos: **aerovial inhalador: budesonida 200 mcg + formoterol 6 mg (capsulas inhalados), uso ocasional, calcio 1200 mg día**
- Alérgicos: niega
- Hospitalarios: niega
- Tóxico: niega consumo de sustancia psicoactivas, cigarrillo o licor
- Familiares: niega
- **Antecedente de preeclampsia madre o hermana : Madre con ant no claro de preeclampsia**
- historia de cáncer heredofamiliar niega
- transfusionales: niega
- **Hemoclasificación materna: o negativo**
- **¿requiere administración de inmunoglobulina anti d en semana 28? si *****
- traumáticos: niega

GINECOLÓGICOS

- Menarquia: 12 años
- Ciclos: 30x5
- **Método anticonceptivo previo: implante subdérmico** FALLO**
- Planificación post parto: implante subdérmico
- ITS: niega
- Tamización de cáncer de cuello uterino: no recuerda

HISTORIA OBSTÉTRICA

- no historia de parto instrumentado
- no historia de macrosomía fetal
- madre con hipertensión gestacional, no claro
- **Embarazo previo : fup: 03/11/2024**
  peso al nacer: 3150 gr- talla : 50 cm- edad gestacional: 38 semanas
  complicaciones: ninguna
  lugar de atención: HRM
- embarazo actual planeado (no) deseado (si) aceptado (si) fallo método anticonceptivo (si)
- primipaternidad: no

Curso de enfermedad antes de la gestación actual

2022

Se registran dos consultas en donde la paciente manifestó, dificultad para respirar, dolor torácico y tos seca persistente

2023

Primera gestación

Parto vaginal sin complicación del 6/7/2023

**Paciente con exámenes de pyp dentro de límites normales, por antc no claso recibió prevención primaria asa y calcio, En semana 34 con IMC 40, recibió tromboprofilaxis.
**Presentó un episodio de tos,seca disnea y dolor torácico 3/3/2023
PNF : Implante subdérmico

2025

19/3/2025 atención en urgencias por cuadro respiratorio : disnea y tos cianosante ** manejo sintomático y egreso
****9/4/2025 c**onsulta con prueba de embarazo positiva refiere S**IBILANCIAS RESPIRATORIAS CON DISNEA GRADO 4 SEGÚN ESCALA MRC, TOS SECA Y DOLOR TORÁCICO. USA BUDESONIDA/FORMOTEROL con mala respuesta - 11/4/2025 *** ingresa a control prenatal**

Controles prenatales

ASISTIÓ A 4 CONTROLES PRENATALES.

EN EL INTERVALO DE SU 3 Y 4 CONTROL TUVO UN INGRESO POR URGENCIAS POR SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIA



DIAGNÓSTICOS
- G2P1V1
- EMBARAZO DE 26.2 SEMANAS
- **ASMA MODERADO SIN MANEJO**

RIESGO OBSTÉTRICO ALTO MADRE CON DIAGNÓSTICO DE THAE
RIESGO ISOINMUNIZACIÓN RH NEGATIVO.
RIESGO TROMBOEMBÓLICO BAJO
RIESGO PSICOSOCIAL: BAJO ESCALA HERRERA Y HURTADO
DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL: SOBREPESO PARA EDAD GESTACIONAL ATHALA IMC 30
RIESGO DE PREECLAMPSIA INTERMEDIO
RIESGO DE HPP BAJO
PLANIFICACIÓN FAMILIAR POST PARTO: IMPLANTE SUBDÉRMICO

PLAN
* HIDRATAN + CORTICOIDE + MNB

EMBARAZO DE 28.5 SEMANAS POR ECOGRAFÍA DE TAMIZAJE, REFIERE SENTIRSE BIEN, REFIERE MOVIMIENTOS FETALES, BUENA ADHERENCIA A MICRONUTRIENTES. NIEGA EPISODIOS DE SANGRADO, ASINTOMÁTICA, NIEGA SÍNTOMAS URINARIOS. NIEGA AMENORREA, NIEGA SÍNTOMAS DE VASOESPASMO- , SIN EMBARGO CON DISNEA NYHA III/ IV, SIN SÍNTOMAS CONGESTIVOS O DE HIPOPERFUSIÓN.
TAS: 124 TAD: 76 TAM: 9.200 F.C.: 101 F.R.: 19 T°: 36 SO2: 95 PERFUSION: <2

31/06/2025 HOLTER RITMO SINUSAL VARIABILIDAD FC CONSERVADA,
8/08/2025 ESPIROMETRÍA PROBABLE RESTRICCIÓN PRE Y POS

IDX
G2P1V1
EMBARAZO DE 28.5 SEMANAS POR ECOGRAFÍA DE TAMIZAJE
ASMA E
TAQUICARDIA SINUSAL PREGESTACIONAL ***
RIESGO OBSTÉTRICO ALTO
RIESGO DE SEROCONVERSIÓN PARA TOXOPLASMA *** IG M NEGATIVO MES DE JUNIO
RIESGO ISOINMUNIZACIÓN RH NEGATIVO O-
ANTE DE MADRE CON THAE
RIESGO TROMBOEMBÓLICO BAJO
RIESGO PSICOSOCIAL: BAJO ESCALA HERRERA Y HURTADO
DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL: SOBREPESO PARA EDAD GESTACIONAL ATHALA IMC 30
RIESGO DE PREECLAMPSIA INTERMEDIO
RIESGO DE HPP BAJO

PAciente con posterior mejoria, exámenes hemograma y pcr normales , **dan egreso con bromuro + beclometasona,se insiste en toma de estudio**

INGRESO A URGENCIAS DEL SERVICIO DE GINECOLOGÍA

~~7/9/2025~~



INGRESA A TRIAJE 6+22

MOTIVO DE CONSULTA: ME SIENTO AHOGADA

ENFERMEDAD ACTUAL

Paciente de 27 años de edad **G2 con embarazo de eg 31.3 semanas** con cuadro clínico **1 día de evolución consistente en disnea de pequeños esfuerzo asociado a disfagia tos ciano zante emetizante sin movilización de secreciones con antecedente de asma, en manejo con bromuro de ipratropio y betametasona sin mejoría de su cuadro**

SIGNOS VITALES SV: TA: 130/80 SPO2: 86% FC: 107 LPM FR: 18 T:37°

Q SOFA 0 -PUNTOS MEOWS 2 PUNTO (RIESGO BAJO)

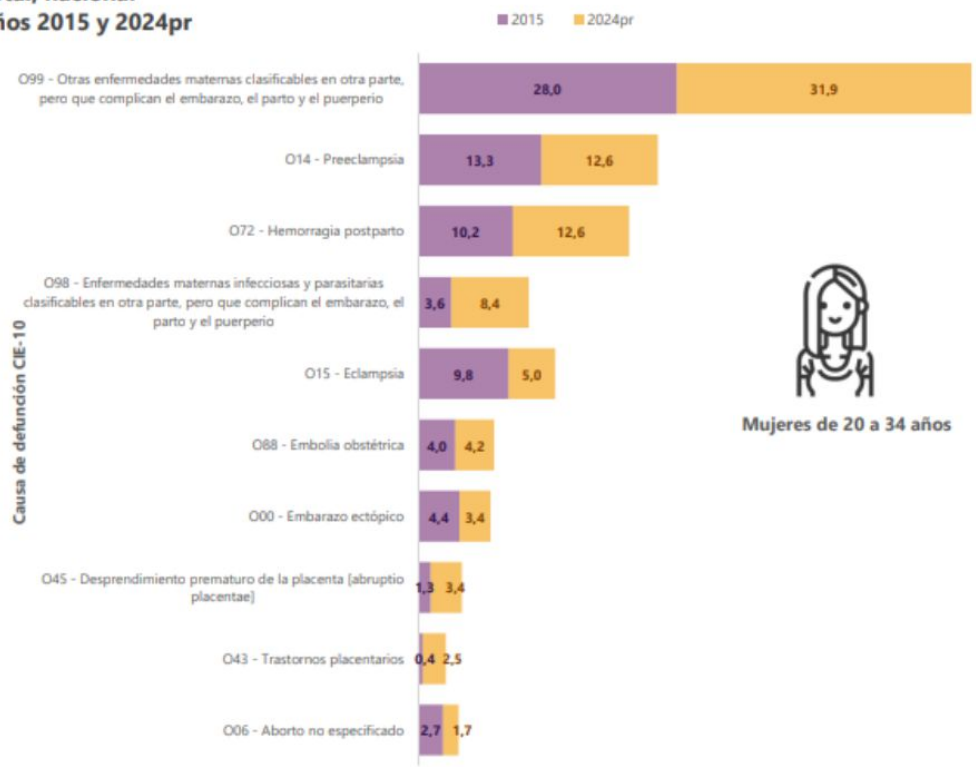
EF : RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS NO MASAS NO MEGALIAS, **RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS NO MASAS NO MEGALIAS, RUIDOS RESPIRATORIOS CON SIBILANCIAS BILATERALES , NO PRESENTA SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA**

IDX
- CRISIS ASMÁTICA
-RIESGO TROMBOEMBÓLICO BAJO

PLAN
L RINGER BOLO DE 500 CC
PARACETAMOL 1 GR IV
MNB CON SALBUTAMOL 20 GOTAS EN 3 CC DE SSN 0.9 % UN CICLO N 3 UNO CADA 20 MINUTOS
HIDROCORTISONA 100 MG IV
S/S CUADRO HEMÁTICO Y PCR

ESTADÍSTICAS

Gráfico 224. Primeras diez causas de muerte materna temprana en madres de 20 a 34 años
Total, nacional
Años 2015 y 2024pr

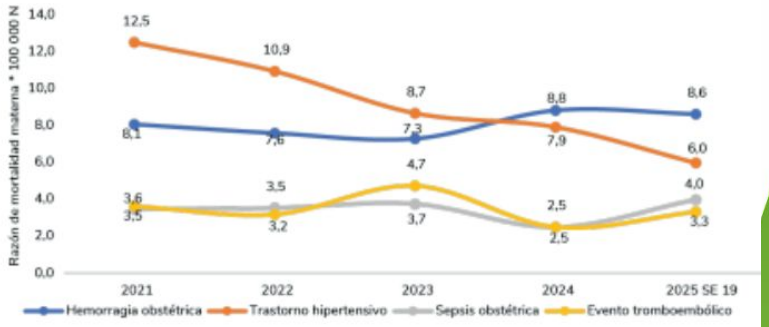


Mujeres de 20 a 34 años

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares

comparadas con el año 2024 (figura 3).

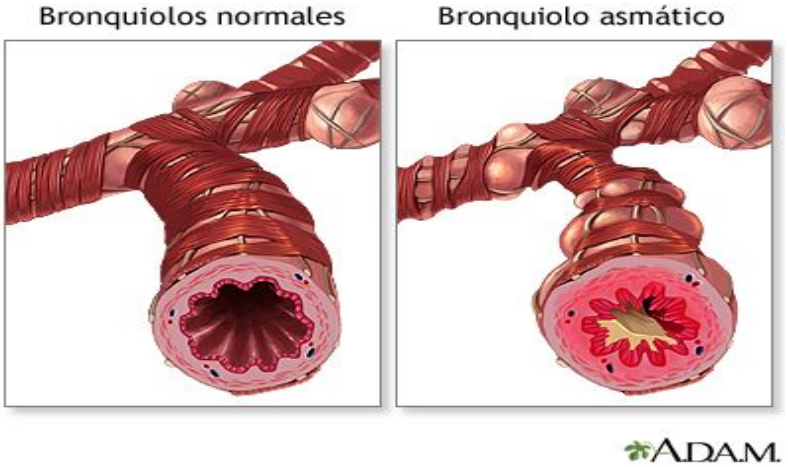
Figura 3. Razón de las principales causas agrupada de muerte materna temprana, Colombia 2020- 2024, semana epidemiológica 19 de 2025



Fuente: numerador: Instituto Nacional de Salud 2021 – 2024, SE 19 2025 cifras preliminares. Denominador: Nacidos vivos DA
2021 a 2023, RUAF ND 2024 – 2025 datos preliminares

Definición

Enfermedad heterogénea, generalmente caracterizada por la inflamación crónica de las vías respiratorias. Se define por la presencia de síntomas respiratorios, como sibilancias, disnea, opresión torácica y tos, que varían con el tiempo y en intensidad, junto con una limitación variable del flujo aéreo espiratorio.



Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. GUÍA ESPAÑOLA PARA EL MANEJO DEL ASMA GEMA 5.5 [Internet]. España: Medscape; 2025 [citado el 27 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://gemasma.elmedicointeractivo.com/profesional/

Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention [Internet]. Estados Unidos; 2024 [citado 27 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2024/05/GINA-2024-Strategy-Report-24_05_22_WMS.pdf#page132

Epidemiología

- Prevalencia del 1- 29% (300 millones de personas)

- 1000 muertes por día
- Aumento de incidencia
- Disminución de mortalidad

- Colombia
- 491.886
- 1.06%

Gráfico 1. Prevalencia nacional registrada por departamento **(SISPRO 2019)**

SISPRO, Sistema Integrado de Información de la Protección Social.

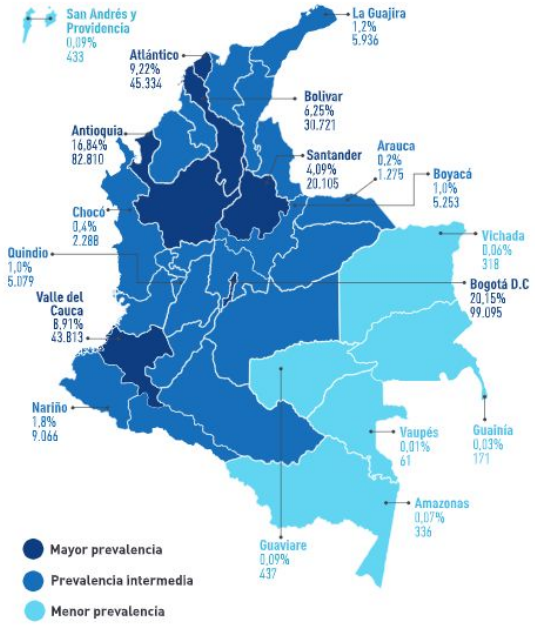
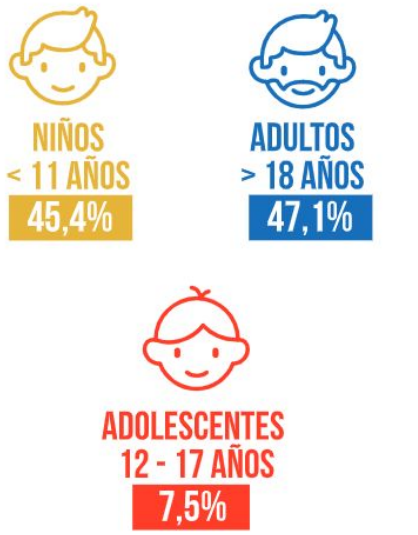


Gráfico 2. Prevalencia nacional registrada por grupo etario **(SISPRO 2019)**

SISPRO, Sistema Integrado de Información de la Protección Social.



Orozco M, Borero L,Botero L, Londoño S, Saenz S. Distribución de la prevalencia de asma resgistrada en Colombia. rev. colomb. neumol.[Internet]. 2023 [citado el 27 de septiembre 2025]; 35(1):1. Disponible en: https://revistas.asoneumocito.org/index.php/rcneumologia/article/view/821/661

Epidemiología

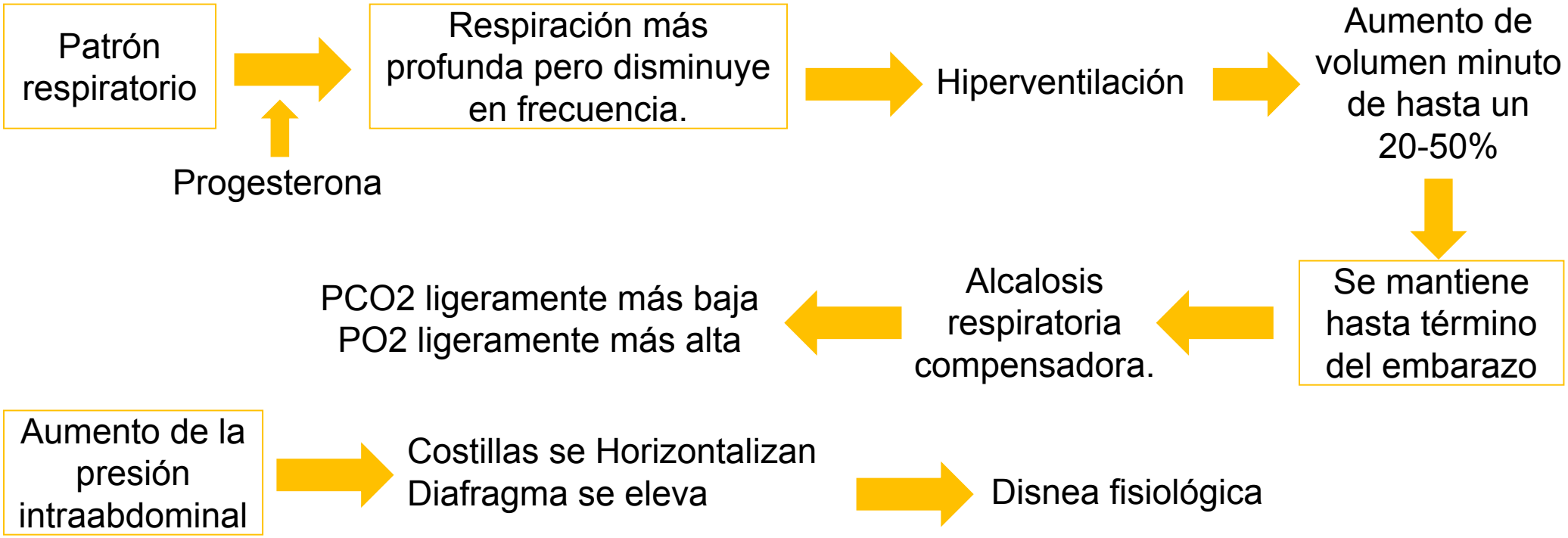
Entre el 2 y el 13% de las embarazadas padece asma, siendo el trastorno respiratorio más frecuente en el embarazo.

Hasta un 18% de las embarazadas con asma empeoran durante el embarazo, aumentando a un 50% en caso de asma grave.



1. Alkourdi A, Villegas J. Patología respiratoria y gestación. Guías asistenciales perinatología. [Internet]. España: Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia; 2023 [Citado el 14 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://sagoandalucia.com/docs/guias/Perinatal/transtornosrespiratoriosyGestacion.pdf

Cambios fisiológicos



1. Alkourdi A, Villegas J. Patología respiratoria y gestación. Guías asistenciales perinatología. [Internet]. España: Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia; 2023 [Citado el 27 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://sagoandalucia.com/docs/guias/Perinatal/transtornosrespiratoriosyGestacion.pdf

Factores de riesgo

Tabla 1.2. Factores asociados a la aparición de asma

Factores de riesgo	Evidencia	Asociación	Tipo de estudio	Referencia
FACTORES DEL HUÉSPED				
Atopia	C	OR 3,5 (2,3-5,3)	b	Arbes 2007[13]
Menarquia temprana	C	OR 1,08 (1,04-1,12)	b	Minelli 2018[14]
Obesidad	B	RR 1,50 (1,22-1,83)	a	Egan 2013[15]
Hiperrespuesta bronquial	C	OR 4,2 (1,92-9,23)	b	Carey 1996[16]
Rinitis	C	OR 3,21 (2,21-4,71)	b	Guerra 2002[17]
	C	OR 4,16 (3,57-4,86)	b	Burgess 2007[18]
	C	RR 3,53 (2,11-5,91)	b	Shaaban 2008[19]
FACTORES PRENATALES Y PERINATALES				
Edad de la madre	C	OR 0,85 (0,79-0,92) **1,4**	b	Gómez 2018[20]
Preeclampsia	C	OR 4,01 (1,11-14,43)	b	Stokholm 2017[21]
Prematuridad	B	OR 2,81 (2,52-3,12) **2**	a	Been 2014[22]
	B	OR 1,37 (1,17-1,62) **3**	a	Been 2014[22]
	C	OR 4,30 (2,33-7,91)	b	Leps 2018[23]
Cesárea	C	HR 1,52 (1,42-1,62)	b	Tollånes 2008[24]
Ictericia neonatal	C	OR 1,64 (1,36-1,98)	b	Ku 2012[25]
Lactancia	C	OR 0,88 (0,82-0,95) **4**	b	Silvers 2012[26]
	B	OR 0,70 (0,60-0,81) **4**	a	Gdalevich 2001[27]
Consumo de tabaco durante la gestación	C	OR 1,72 (1,11-2,67)	b	Strachan 1996[28]
	A	OR 1,85 (1,35-2,53)	a	Burke 2012[29]
	C	OR 2,70 (1,13-6,45)	b	Cunningham 1996[30]
	C	OR 1,65 (1,18-2,31)	b	Neuman 2012[31]
Dieta de la madre	C	OR 0,49 (0,27-0,90) **2,4**	b	Litonjua 2006[32]
	A	OR 0,54 (0,33-0,88) **5,4**	a	Wolks 2017[33]
	C	OR 0,33 (0,11-0,98) **4**	b	Devereux 2007[34]
	A	OR 0,86 (0,78-0,95) **6,4**	a	García-Marcos 2013[35]
Dieta del lactante	A	RR 0,66 (0,47-0,94) **7,4**	d	Hibbs 2018[36]
Función pulmonar del neonato	C	OR 2,10 (1,12-3,93)	b	Håland 2006[37]
Sobrepeso de la madre	A	OR 1,09 (1,00, 1,19)	b	Rosenquist 2023[38]
Obesidad de la madre	A	OR 1,10 (0,99, 1,21)	b	Rosenquist 2023[38]

HR: *hazard ratio*; OR: *odds ratio*. Tipo de estudio: a metanálisis-revisión sistemática, b estudio epidemiológico prospectivo, c estudio epidemiológico retrospectivo, d ensayo clínico.

Comentarios: **1** en sexo femenino, **2** muy prematuros, **3** moderadamente prematuros, **4** factor protector, **5** nivel de vitamina D al comienzo de la gestación, **6** dieta mediterránea, **7** suplemento de vitamina D, **8** exposición a perro, **9** exposición a gato, **10** vivir en granja, **11** infección viral no respiratoria, **12** tabaquismo pasivo, **13** no asociación, **14** exposición prenatal, **15** exposición postnatal, **16** sólo con estrógenos.

Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. GUÍA ESPAÑOLA PARA EL MANEJO DEL ASMA GEMA 5.5 [Internet]. España: Medscape; 2025 [citado el 27 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://gemasma.elmedicointeractivo.com/profesional/

Factores de riesgo

Tabla 1.2. Factores asociados a la aparición de asma

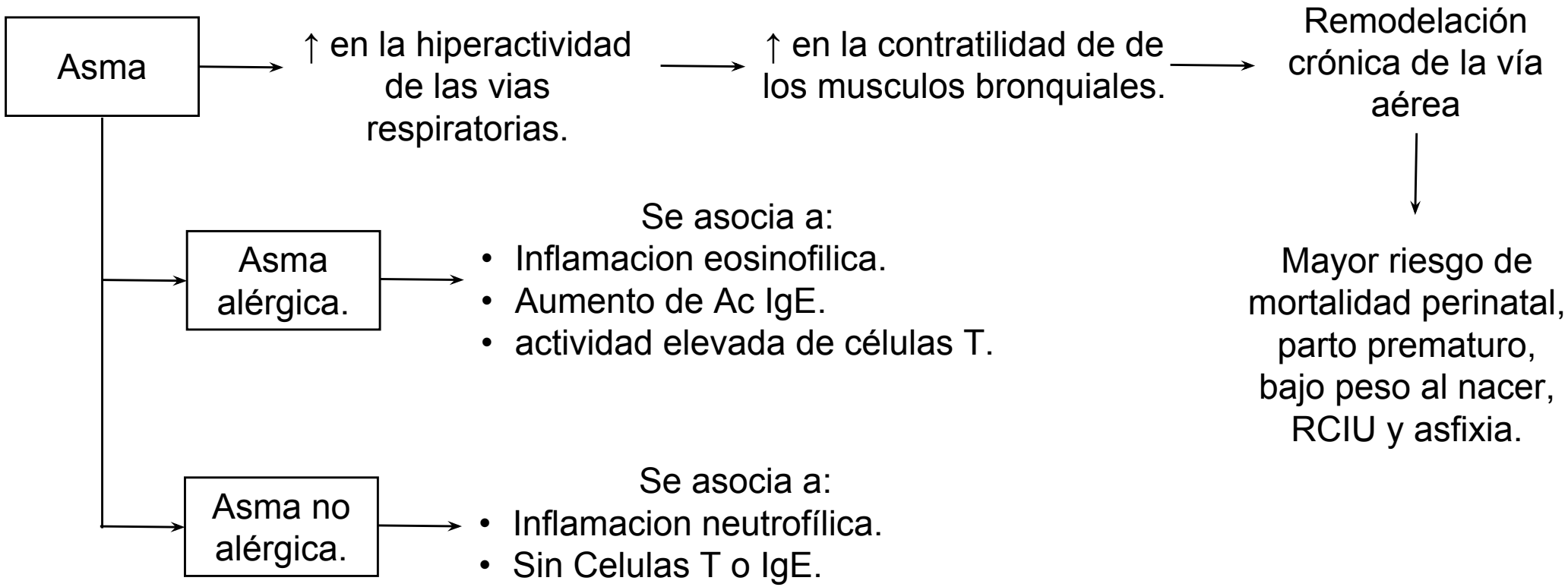
Factores de riesgo	Evidencia	Asociación	Tipo de estudio	Referencia
FACTORES AMBIENTALES				
Aeroalérgenos	C	OR 0,49 (0,29-0,83) **8,4**	b	Kerkhof 2009[39]
	C	OR 0,68 (0,49-0,95) **9,4**	b	Kerkhof 2009[39]
Alérgenos laborales	C	RR 2,2 (1,3-4,0)	b	Kogevinas 2007[40]
	C	OR 0,55 (0,43-0,70) **10,4**	b	Hoppin 2008[41]
Infecciones respiratorias	C	OR 0,52 (0,29-0,92) **11,4**	b	Illi 2001[42]
Tabaco	C	RR 3,9 (1,7-8,5)	b	Gilliland 2006[43]
	C	HR 1,43 (1,15-1,77)	b	Coogan 2015[44]
	C	HR 1,21 (1,00-1,45) **12**	b	Coogan 2015[44]
Contaminación ambiental	A	OR 1,34 (1,17-1,54)	a	Orellano 2018[45]
FÁRMACOS				
Paracetamol	C	OR 1,26 (1,02-1,58)	b	Sordillo 2015[46]
Antiácidos	A	RR 1,45 (1,35-1,56)	a	Lai 2018[47]
Antibióticos	B	OR 1,12 (0,88-1,42) **13**	a	Marra 2006[48]
	C	OR 0,6 (0,4-0,96) **4**	b	Goksör 2013[49]
	C	HR 1,23 (1,20-1,27) **14**	b	Loewen 2018[50]
	C	OR 1,75 (1,40-2,17) **15**	b	Hoskin-Parr 2013[51]
Terapia hormonal sustitutiva	C	HR (1,54 (1,13-2,09) **16**	b	Romieu 2010[52]

HR: *hazard ratio*; OR: *odds ratio*. Tipo de estudio: a metanálisis-revisión sistemática, b estudio epidemiológico prospectivo, c estudio epidemiológico retrospectivo, d ensayo clínico.

Comentarios: **1** en sexo femenino, **2** muy prematuros, **3** moderadamente prematuros, **4** factor protector, **5** nivel de vitamina D al comienzo de la gestación, **6** dieta mediterránea, **7** suplemento de vitamina D, **8** exposición a perro, **9** exposición a gato, **10** vivir en granja, **11** infección viral no respiratoria, **12** tabaquismo pasivo, **13** no asociación, **14** exposición prenatal, **15** exposición postnatal, **16** sólo con estrógenos.

Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. GUÍA ESPAÑOLA PARA EL MANEJO DEL ASMA GEMA 5.5 [Internet]. España: Medscape; 2025 [citado el 27 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://gemasma.elmedicointeractivo.com/profesional/

Fisiopatología



Kemppainen M, Gissler M, Kirjavainen T. Maternal asthma during pregnancy and the likelihood of neurodevelopmental disorders in offspring. Acta Obstet Gynecol Scand. [Internet]. 2024. [Citado el 27 de septiembre de 2025]; 104(1):235-244. Disponible en: DOI: 10.1111/aogs.15008

Resultados adversos

Materno	Perinatal	Fetal
Hemorragia pre y post parto	Placenta previa	Muerte fetal
Cesárea de urgencia	Desprendimiento de placenta	Hospitalización neonatal
Diabetes gestacional	Ruptura prematura de membranas	Bajo peso al nacer
Hipertensión arterial gestacional		Recién nacido pequeño para edad gestacional
Preeclampsia		Fisura labio-palatina

(Adaptado de Bonham et al)[7].

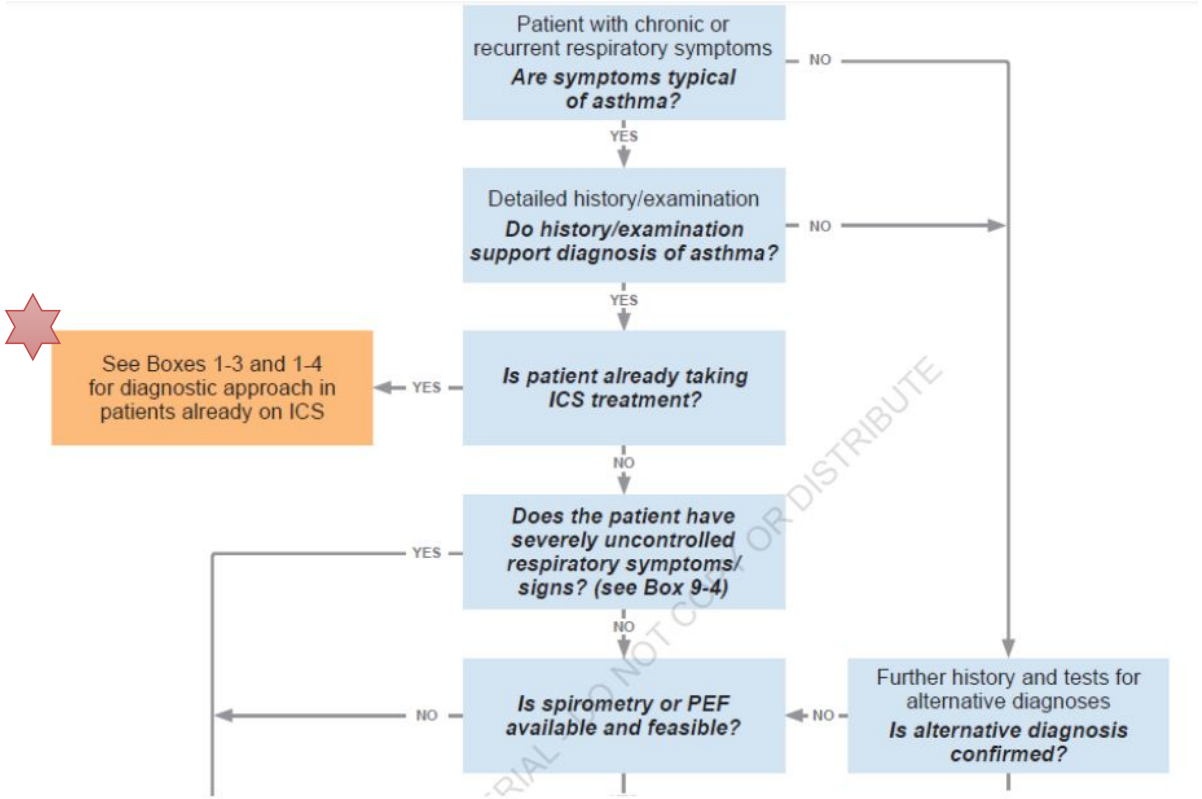
Barria P. Asma y embarazo: fisiopatología, diagnóstico y manejo farmacológico. REV. MED. CLIN. CONDE [Internet]. 2024 [Citado el 27 de septiembre de 2025]; 35(3-4): 221-231 Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-pdf-S0716864024000324

Signos y síntomas orientadores

Síntomas que aumentan la probabilidad de asma	Síntomas que disminuyen la probabilidad de asma
Más de 1 síntoma: tos, disnea, sibilancias, pecho apretado	Mareos, hormigueos en extremidades
Gatillantes: ejercicio, aire frio, pólenes	Examen físico normal durante síntomas
Aparecen en la noche o temprano en la mañana/al amanecer	Tos crónica con expectoración (ej. bronquiectasias)
Aparecen post ingesta de aspirina, antinflamatorios no esteroi-dales o beta bloqueadores	Historia previa de tabaquismo importante
Historia de rinitis alérgica o atopia cutánea/alimentos	Tos aislada
Variabilidad del PEF	PEF normal durante episodio de síntomas
Sibilancias variables a la auscultación pulmonar	Comorbilidad cardiovascular
Historia de asma en familiar primer grado (hermanos o padres)	Disfonia persistente de predominio matinal que mejora durante el día (¿reflujo faringo-laringeo?)

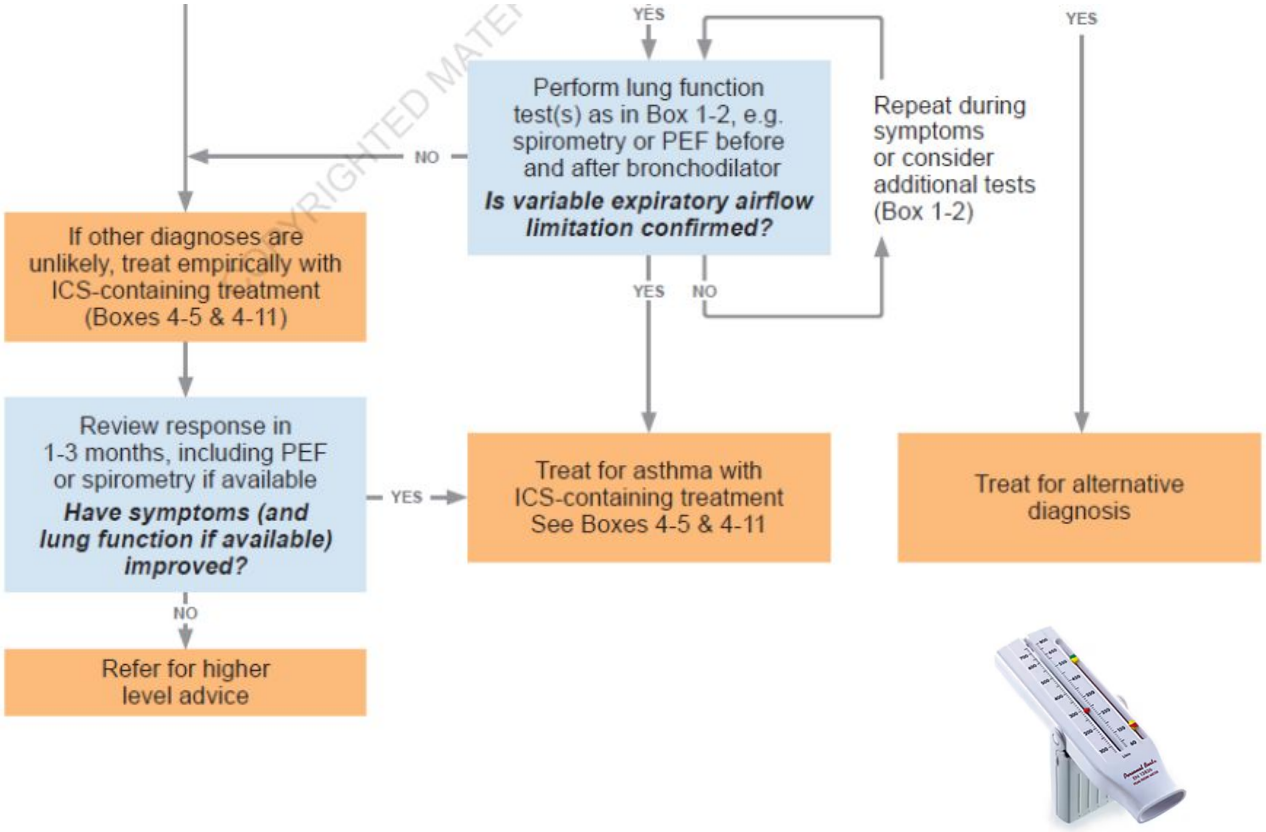
Barria P. Asma y embarazo: fisiopatología, diagnóstico y manejo farmacológico. REV. MED. CLIN. CONDE [Internet]. 2024 [Citado el 27 de septiembre de 2025]; 35(3-4): 221-231 Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-pdf-S0716864024000324

Diagnóstico



Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention [Internet]. Estados Unidos; 2024 [citado 27 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2024/05/GINA-2024-Strategy-Report-24_05_22_WMS.pdf#page132

Diagnóstico



Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention [Internet]. Estados Unidos; 2024 [citado 27 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2024/05/GINA-2024-Strategy-Report-24_05_22_WMS.pdf#page132

Diagnóstico

Box 1-2. Criteria for initial diagnosis of asthma in adults, adolescents, and children 6–11 years

1. HISTORY OF TYPICAL VARIABLE RESPIRATORY SYMPTOMS	
Feature	*Symptoms or features that support the diagnosis of asthma*
Wheeze, shortness of breath, chest tightness and/or cough (Descriptors may vary between cultures and by age)	• Symptoms occur variably over time and vary in intensity • Symptoms are often worse at night or on waking • Symptoms are often triggered by exercise, laughter, allergens, cold air • Symptoms often appear or worsen with viral infections

Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention [Internet]. Estados Unidos; 2024 [citado 27 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2024/05/GINA-2024-Strategy-Report-24_05_22_WMS.pdf#page132

Diagnóstico

2. CONFIRMED VARIABLE EXPIRATORY AIRFLOW LIMITATION	
Feature	*Considerations, definitions, criteria*
Excessive variability in expiratory lung function (one or more of the following):	The greater the variations, or the more occasions excess variation is seen, the more confident the diagnosis of asthma. If initially negative, tests can be repeated during symptoms or in the early morning. If spirometry is not possible, PEF† may be used, but it is less reliable.
Positive bronchodilator (BD) responsiveness (reversibility) test with spirometry (or PEF†)	*Adults*: increase from baseline in FEV_1 or FVC of ≥12% and ≥200 mL, with greater confidence if the increase is ≥15% and ≥400 mL; or increase in PEF† ≥20% if spirometry is not available. *Children*: increase from baseline in FEV_1 of ≥12% predicted (or in PEF† of ≥15%). Measure change 10–15 minutes after 200–400 mcg salbutamol (albuterol) or equivalent, compared with pre-BD readings. Positive test more likely if BD withheld before test: SABA ≥4 hours, long-acting bronchodilators 24–48 hours (see below).
Excessive variability in twice-daily PEF over 2 weeks*	*Adults*: average daily diurnal PEF variability >10%* *Children*: average daily diurnal PEF variability >13%*
Increase in lung function after 4 weeks of treatment	*Adults*: increase from baseline in FEV_1 by ≥12% and ≥200 mL (or PEF† by ≥20%) after 4 weeks of daily ICS-containing treatment *Children*: increase from baseline in FEV_1 of ≥12% predicted (or in PEF† of ≥15%).
Positive bronchial challenge test	*Adults*: Fall from baseline in FEV_1 of ≥20% with standard doses of methacholine, or ≥15% with standardized hyperventilation, hypertonic saline or mannitol challenge, or >10% and >200 mL with standardized exercise challenge. *Children*: fall from baseline in FEV_1 of >12% predicted (or fall in PEF† >15%) with standardized exercise challenge. If FEV_1 decreases during a challenge test, check that FEV_1/FVC ratio has also decreased, since incomplete inhalation, e.g., due to inducible laryngeal obstruction or poor effort, can result in a false reduction in FEV_1.
Excessive variation in lung function between visits (good specificity but poor sensitivity)	*Adults*: variation in FEV_1 of ≥12% and ≥200 mL (or in PEF† of ≥20%) between visits. *Children*: variation in FEV_1 of ≥12% in FEV_1 (or ≥15% in PEF†) between visits

Current status	Steps to confirm the diagnosis of asthma
Variable respiratory symptoms and variable airflow limitation	**Diagnosis of asthma is confirmed.** Assess the level of asthma control (Box 2-2A and Box 2-2B, p.37) and review ICS-containing treatment (Box 4-6, p.77; Box 4-12, p.96.)
Variable respiratory symptoms but no variable airflow limitation	**Consider repeating spirometry** (or PEF*) after withholding bronchodilator (4 hrs for SABA, 24–48 hrs for long-acting bronchodilators (see below) or during symptoms. Check between-visit variability of FEV_1, and bronchodilator responsiveness. If still normal, consider other diagnoses (Box 1-3, p.27). *If FEV_1 (or PEF*) is >70% predicted*: consider stepping down ICS-containing treatment (see Box 1-5, p.32) and reassess in 2–4 weeks, then consider bronchial provocation test or repeating bronchodilator responsiveness test. *If FEV_1 (or PEF*) is <70% predicted*: consider starting or stepping up maintenance ICS-containing treatment for 3 months (Box 4-6, p.77), then reassess symptoms and lung function. If no response, resume previous ICS dose and refer patient for diagnosis and investigation.
Few respiratory symptoms, normal lung function, and no variable airflow limitation	**Consider repeating BD responsiveness test** again after withholding bronchodilator as above or during symptoms. If normal, consider investigation for alternative diagnoses (Box 1-3, p.27). **Consider stepping down ICS-containing treatment** (see Box 1-5, p.32): • *If symptoms emerge and lung function falls*: asthma is confirmed. Step up ICS-containing treatment to previous lowest effective dose. • *If no change in symptoms or lung function at lowest controller step*: consider ceasing maintenance ICS-containing treatment, or switching to as-needed-only ICS-formoterol, and monitor patient closely for at least 12 months (Box 4-13, p.102).
Persistent shortness of breath and persistent airflow limitation	**Consider stepping up ICS-containing treatment for 3 months** (Box 4-6, p.77), then reassess symptoms and lung function. If no response, resume previous ICS dose and refer patient for further investigation and management, or manage as for patients with features of both asthma and COPD (Section 7, p.131).

Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention [Internet]. Estados Unidos; 2024 [citado 27 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2024/05/GINA-2024-Strategy-Report-24_05_22_WMS.pdf#page132

Diagnóstico diferencial

12–39 years	Sneezing, itching, blocked nose, throat-clearing	Chronic upper airway cough syndrome
	Dyspnea, inspiratory wheezing (stridor)	Inducible laryngeal obstruction
	Dizziness, paresthesia, sighing	Hyperventilation, dysfunctional breathing
	Productive cough, recurrent infections	Bronchiectasis
	Excessive cough and mucus production	Cystic fibrosis
	Cardiac murmurs	Congenital heart disease
	Shortness of breath, family history of early emphysema	$Alpha_1$-antitrypsin deficiency
	Sudden onset of symptoms	Inhaled foreign body
40+ years	Dyspnea, inspiratory wheezing (stridor)	Inducible laryngeal obstruction
	Dizziness, paresthesia, sighing	Hyperventilation, dysfunctional breathing
	Cough, sputum, dyspnea on exertion, smoking or noxious exposure	COPD*
	Productive cough, recurrent infections	Bronchiectasis
	Dyspnea with exertion, nocturnal symptoms, ankle edema	Cardiac failure
	Treatment with angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor	Medication-related cough
	Dyspnea with exertion, non-productive cough, finger clubbing	Parenchymal lung disease
	Sudden onset of dyspnea, chest pain	Pulmonary embolism
	Dyspnea, unresponsive to bronchodilators	Central airway obstruction

Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention [Internet]. Estados Unidos; 2024 [citado 27 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2024/05/GINA-2024-Strategy-Report-24_05_22_WMS.pdf#page132

Pruebas diagnósticas para la detección

Test para evaluar obstrucción bronquial variable	Criterio diagnostico
Espirometría con obstrucción bronquial reversible post broncodilatador	Índice FEV1/CVF reducido con aumento en el FEV1 de >12 % y >200 ml post salbutamol (400 µg)
Aumento de la variabilidad de PEF	Variabilidad >20%, se calcula: PEF máx-PEF min/PEF máx ó PEF máx-PEF min/(PEF máx+PEF min)/2

Barria P. Asma y embarazo: fisiopatología, diagnóstico y manejo farmacológico. REV. MED. CLIN. CONDE [Internet]. 2024 [Citado el 27 de septiembre de 2025]; 35(3-4): 221-231 Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-pdf-S0716864024000324

Tratamiento

Objetivos de manejo en gestante.

Lograr un adecuado control de los síntomas de asma → Prevenir las crisis o exacerbaciones → Mantener una función pulmonar normal

- Identificar desencadenantes
- Conocer y distinguir funcion de medicamentos
- Reforzar vacunación
- Educación de técnica de inhaloterapia
- Plan de manejo individualizado.

Barria P. Asma y embarazo: fisiopatología, diagnóstico y manejo farmacológico. REV. MED. CLIN. CONDE [Internet]. 2024 [Citado el 27 de septiembre de 2025]; 35(3-4): 221-231 Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-pdf-S0716864024000324

Tipos De Tratamiento

Glucocorticoides inhalados (GCI) o sistémicos.

Antagonistas de los receptores de los leucotrienos (ARLT): Montelukast

Agonistas β2 adrenérgicos de acción prolongada (LABA): Formoterol, Salmeterol, Vilanterol, Indacaterol.

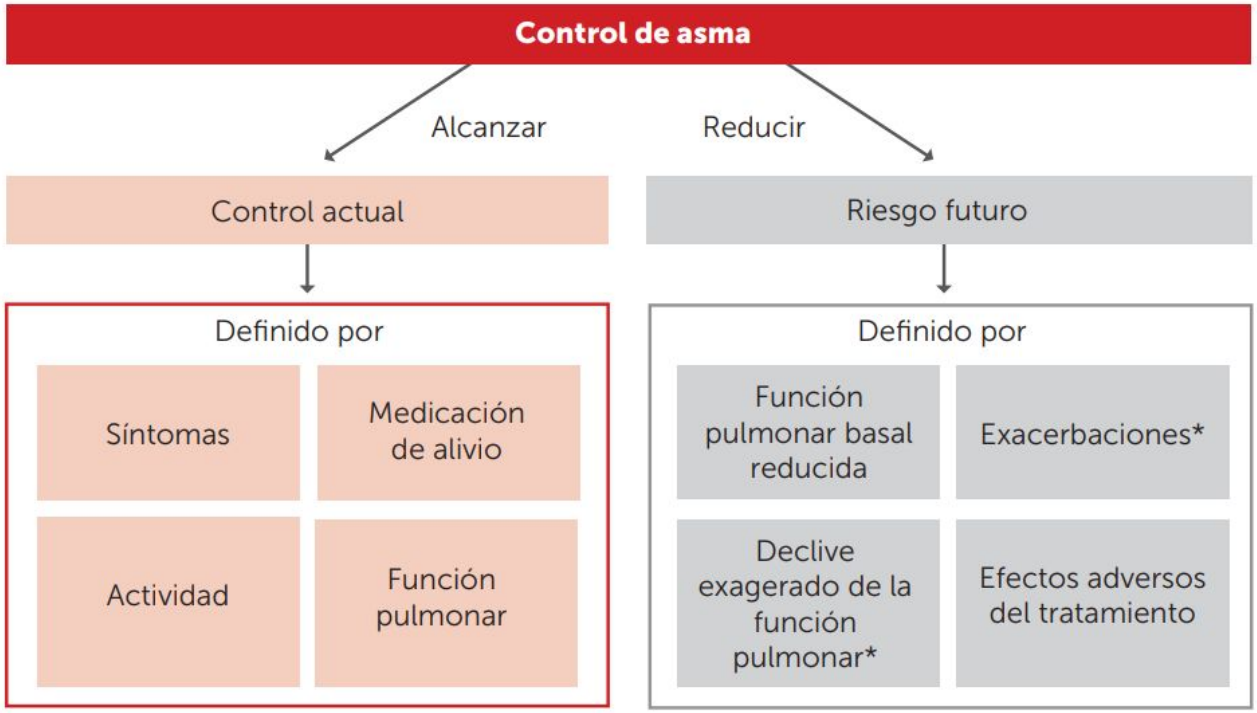
Anticolinérgicos: Bromuro de tiotropio

Agonistas B2 adrenérgicos de acción corta (SABA): Salbutamol, Terbutalina

Anticolinérgicos de acción corta inhalados: Bromuro de ipratropio

1. Alkourdi A, Villegas J. Patología respiratoria y gestación. Guías asistenciales perinatología. [Internet]. España: Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia; 2023 [Citado el 27 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://sagoandalucia.com/docs/guias/Perinatal/transtornosrespiratoriosyGestacion.pdf

Control de la enfermedad



Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. GUÍA ESPAÑOLA PARA EL MANEJO DEL ASMA GEMA 5.5 [Internet]. España: Medscape; 2025 [citado el 27 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://gemasma.elmedicointeractivo.com/profesional/

Control de la enfermedad

Box 2-2. GINA assessment of asthma control at clinical visits in adults, adolescents and children 6–11 years

A. Recent asthma symptom control (but also ask the patient/caregiver about the whole period since last review#)

In the past 4 weeks, has the patient had:		Well controlled	Partly controlled	Uncontrolled
• Daytime asthma symptoms more than twice/week?	Yes☐ No☐	None of these	1–2 of these	3–4 of these
• Any night waking due to asthma?	Yes☐ No☐			
• SABA* reliever for symptoms more than twice/week?	Yes☐ No☐			
• Any activity limitation due to asthma?	Yes☐ No☐			

Factors that increase the risk of exacerbations even if the patient has few asthma symptoms†

- *SABA over-use:* High SABA use (≥3 x 200-dose canisters/year associated with increased risk of exacerbations, increased mortality particularly if ≥1 canister per month)[86-89]
- *Inadequate ICS*: not prescribed ICS, poor adherence,[90] or incorrect inhaler technique[91]
- *Other medical conditions:* Obesity,[92,93] chronic rhinosinusitis,[93] GERD,[93] confirmed food allergy,[94] pregnancy[95]
- *Exposures:* Smoking,[96] e-cigarettes,[97] allergen exposure if sensitized,[96,98] air pollution[99-102]
- *Psychosocial*: Major psychological or socioeconomic problems[103,104]
- *Lung function:* Low FEV_1 (especially <60% predicted),[96,105] high bronchodilator responsiveness[93,106,107]
- *Type 2 inflammatory markers:* Higher blood eosinophils,[93,108,109] high FeNO (adults with allergic asthma on ICS)[110]
- *Exacerbation history:* Ever intubated or in intensive care unit for asthma;[111] ≥1 severe exacerbation in last year[112,113]

b. Risk factors for developing persistent airflow limitation

- *History:* Preterm birth, low birth weight and greater infant weight gain,[114] chronic mucus hypersecretion[115,116]
- *Medications:* Lack of ICS treatment in patient with history of severe exacerbation[117]
- *Exposures:* Tobacco smoke,[115] noxious chemicals; occupational or domestic exposures[62]
- *Investigation findings:* Low initial FEV_1,[116] sputum or blood eosinophilia[116]

c. Risk factors for medication side-effects

- *Systemic* Frequent OCS, long-term, high-dose and/or potent ICS, P450 inhibitors[118]
- *Local:* High-dose or potent ICS,[118,119] poor inhaler technique[120]

COPYRIGHTED BY GINA 2024 - DO NOT COPY

Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention [Internet]. Estados Unidos; 2024 [citado 27 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2024/05/GINA-2024-Strategy-Report-24_05_22_WMS.pdf#page132

Control de la enfermedad

Tabla 2.6. Clasificación del control del asma en adultos

	Bien controlada *(Todos los siguientes)*	Parcialmente controlada *(Cualquier medida en cualquier semana)*	Mal controlada
Síntomas diurnos	Ninguno o ≤ 2 días al mes	> 2 días al mes	Si ≥ 3 características de asma parcialmente controlada
Limitación de actividades	Ninguna	Cualquiera	
Síntomas nocturnos/ despertares	Ninguno	Cualquiera	
Necesidad medicación de alivio (rescate) (agonista β_2 adrenérgico de acción corta)	Ninguna o ≤ 2 días al mes	> 2 días al mes	
Función pulmonar			
FEV_1	≥ 80 % del valor teórico o z-score (-1,64)	< 80 % del valor teórico z-score (-1,64)	
PEF	≥ 80 % del mejor valor personal	< 80 % del mejor valor personal	
Exacerbaciones	Ninguna	≥ 1/año	≥ 1 en cualquier semana

Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. GUÍA ESPAÑOLA PARA EL MANEJO DEL ASMA GEMA 5.5 [Internet]. España: Medscape; 2025 [citado el 27 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://gemasma.elmedicointeractivo.com/profesional/

Manejo no farmacológico

- Cesación del tabaquismo
- Actividad física
- Programas de rehabilitación pulmonar
- Evitar exposiciones
- Evitar sustancias que empeoren los síntomas
- Dieta saludable
- Disminución del peso
- Evitar contaminación
- Salud Mental

Manejo farmacológico

ICS: Corticosteroides inhalados
LABA: Agonistas Beta2 de Larga Acción
LAMA: Antagonistas Muscarínicos de Larga Acción
LTRA: Antagonista del Receptor de Leucotrieno
OCS: Corticosteroides Orales
SABA: Agonistas Beta2 de Corta Acción

Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention [Internet]. Estados Unidos; 2024 [citado 27 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2024/05/GINA-2024-Strategy-Report-24_05_22_WMS.pdf#page132

Manejo farmacológico

- Controlador: Reducir la inflamación
- LABA + ICS
- AIR o MART

- Aliviador: Control de síntomas agudos
- LABA + ICS
- SABA+ ICS



Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention [Internet]. Estados Unidos; 2024 [citado 27 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2024/05/GINA-2024-Strategy-Report-24_05_22_WMS.pdf#page132

Manejo farmacológico

Anti-inflammatory reliever (AIR)	Reliever inhaler that contains both a low-dose ICS and a rapid-acting bronchodilator	Includes budesonide-formoterol, beclometasone-formoterol and ICS-salbutamol combinations. Patients can also use AIRs as needed before exercise or allergen exposure to prevent asthma symptoms and bronchoconstriction. Non-formoterol LABAs in combination with ICS cannot be used as relievers. ICS-formoterol should not be used as the reliever with maintenance ICS-non-formoterol LABAs (p.69).[14] The anti-inflammatory effect of as-needed ICS-formoterol was demonstrated by reduction in FeNO in several studies.[187,188,294] Some anti-inflammatory relievers can be used as-needed at Steps 1–2 as the person's sole asthma treatment, without a maintenance treatment ('**AIR-only**' treatment). Almost all evidence for this is with ICS-formoterol. Some ICS-formoterol combinations can be used as both maintenance treatment and reliever treatment at Steps 3–5 (see **MART**, below). For medications and doses, see Box 4-8 (p.84).
Maintenance-and-reliever therapy (MART)	Treatment regimen in which the patient uses an ICS-formoterol inhaler every day (maintenance dose), and also uses the same medication as needed for relief of asthma symptoms (reliever doses)	**MART** (**M**aintenance-**A**nd-**R**eliever **T**herapy) can be used only with combination ICS-formoterol inhalers such as budesonide-formoterol and beclometasone-formoterol. Other ICS-formoterol inhalers can also potentially be used, but combinations of ICS with non-formoterol LABAs, or ICS-SABA, cannot be used for MART. MART is also sometimes called SMART (single-inhaler maintenance-and-reliever therapy); the meaning is the same. For medications and doses, see Box 4-8 (p.84).

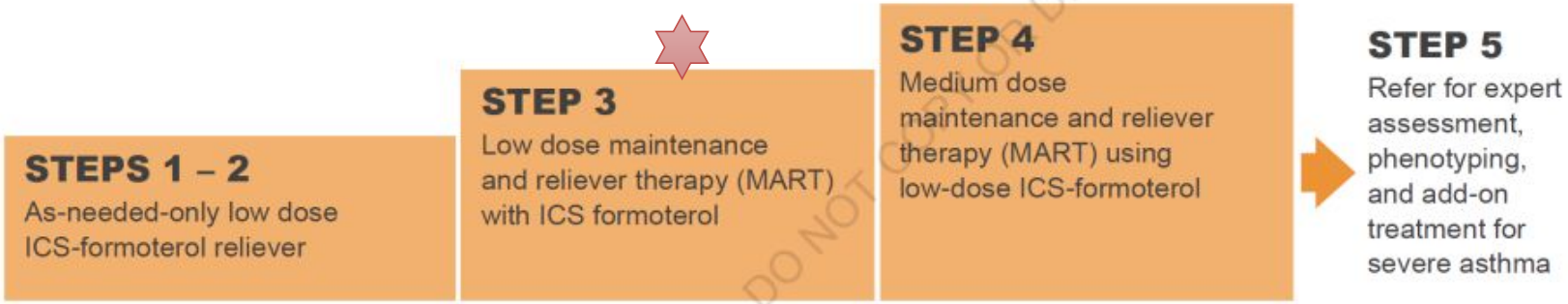
COPYRIGHTED MATERIAL

No tiene controlador
(Sin ICS por horario)
Tiene Aliviador
(ICS/LABA)

Tiene controlador y
Aliviador
(ICS/Formoterol)

Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention [Internet]. Estados Unidos; 2024 [citado 27 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2024/05/GINA-2024-Strategy-Report-24_05_22_WMS.pdf#page132

Manejo farmacológico



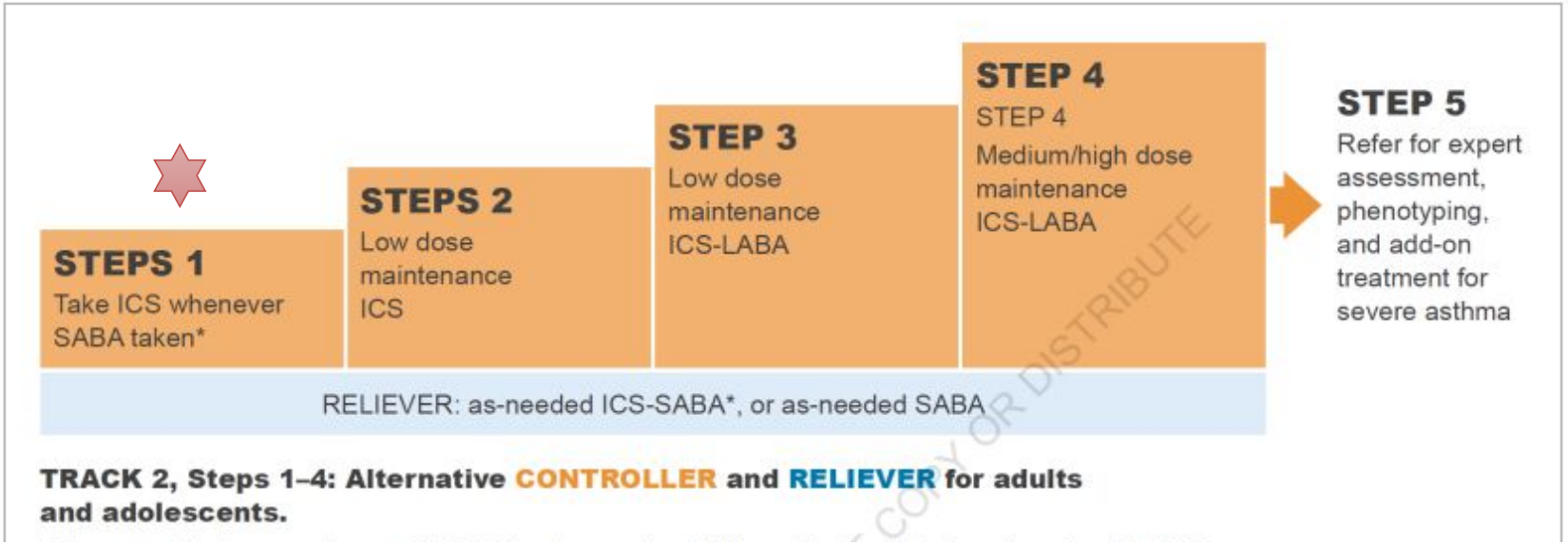
TRACK 1, Steps 1–4: PREFERRED CONTROLLER and RELIEVER for adults and adolescents.

≥18 years	Budesonide-formoterol 200/6 *[160/4.5]* **DPI** or BDP-formoterol 100/6 **pMDI** or **DPI** (maximum total 12 inhalations in any day†)	Step 1–2 (AIR-only): 1 inhalation as needed† Step 3 MART: 1 inhalation twice (or once) daily plus 1 as needed Step 4 MART: 2 inhalations twice daily plus 1 as needed Step 5 MART: 2 inhalations twice daily plus 1 as needed

Máximo 12 inhalaciones

Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention [Internet]. Estados Unidos; 2024 [citado 27 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2024/05/GINA-2024-Strategy-Report-24_05_22_WMS.pdf#page132

Manejo farmacológico



Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention [Internet]. Estados Unidos; 2024 [citado 27 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2024/05/GINA-2024-Strategy-Report-24_05_22_WMS.pdf#page132

Manejo farmacológico

- STEP 1-2
- Inmunoterapia sublingual
- LTRA (Montelukast)
- ICS por horario en estación si es asma estacional pura

- Step 3
- Inmunoterapia sublingual
- ICS a dosis intermedia, LTRA, teofilina

- STEP 4
- Añadir LAMA
- Triple terapia
- ICS a dosis altas

Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention [Internet]. Estados Unidos; 2024 [citado 27 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2024/05/GINA-2024-Strategy-Report-24_05_22_WMS.pdf#page132

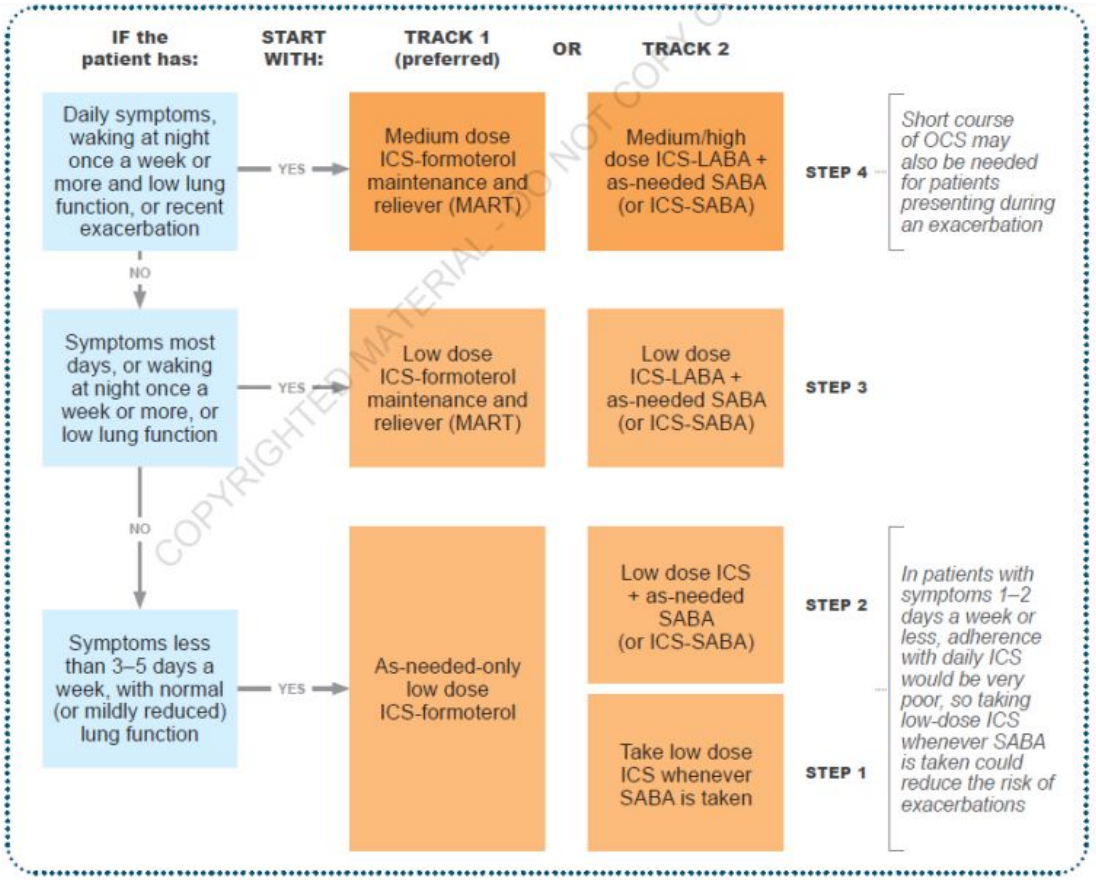
STEP 5

- Remisión a clínica de asma
- ICS/LABA a dosis altas
- ICS/LABA/LAMA
- Consideración de biológicos
- Azitromicina
- Corticoesteroides orales



Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention [Internet]. Estados Unidos; 2024 [citado 27 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2024/05/GINA-2024-Strategy-Report-24_05_22_WMS.pdf#page132

Manejo farmacológico



Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. GUÍA ESPAÑOLA PARA EL MANEJO DEL ASMA GEMA 5.5 [Internet]. España: Medscape; 2025 [citado el 27 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://gemasma.elmedicointeractivo.com/profesional/

Educación

Tabla 3.5. Información y habilidades básicas que debe aprender un paciente con asma

1. **Conocer** que el asma es una enfermedad crónica y necesita tratamiento continuo, aunque no tenga molestias.
2. **Saber** las diferencias que existen entre inflamación y broncoconstricción.
3. **Diferenciar** los fármacos "controladores" de la inflamación, de los "aliviadores" de la obstrucción.
4. **Reconocer** los síntomas de la enfermedad.
5. **Usar** correctamente los inhaladores.
6. **Identificar** y evitar en lo posible los desencadenantes.
7. **Monitorizar** los síntomas y el flujo espiratorio máximo (PEF).
8. **Reconocer** los signos y síntomas de agravamiento de la enfermedad (pérdida del control).
9. **Actuar** ante un deterioro de su enfermedad para prevenir la crisis o exacerbación.

Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. GUÍA ESPAÑOLA PARA EL MANEJO DEL ASMA GEMA 5.5 [Internet]. España: Medscape; 2025 [citado el 27 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://gemasma.elmedicointeractivo.com/profesional/

Tabla 3.6. Plan de acción en asma

A. Estándar

I. TRATAMIENTO HABITUAL

1.- Tomar diariamente _____

2.- Antes del ejercicio tome _____

II. CUÁNDO DEBE INCREMENTAR SU TRATAMIENTO

1. Valoración del grado de control de su asma

¿Tiene más de dos veces al día síntomas de asma?	No	Sí
¿Su actividad o ejercicio físico se encuentra limitado por el asma?	No	Sí
¿Le despierta el asma por la noche?	No	Sí
¿Necesita tomar su broncodilatador más de dos veces al día?	No	Sí
Si utiliza su medidor de flujo (PEF), ¿los valores son inferiores a _____?	No	Sí

Si ha respondido Sí en tres o más de las preguntas, su asma no se encuentra bien controlada y es necesario aumentar su tratamiento habitual

Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. GUÍA ESPAÑOLA PARA EL MANEJO DEL ASMA GEMA 5.5 [Internet]. España: Medscape; 2025 [citado el 27 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://gemasma.elmedicointeractivo.com/profesional/

2. Cómo se incrementa el tratamiento

Aumente su tratamiento de la manera siguiente y valore su mejora diariamente:

_____ (Escriba el aumento del nuevo tratamiento)

Mantenga este tratamiento durante _____días (especifique el número).

3. Cuándo debe pedir ayuda al médico/hospital

Llame a su médico/hospital _____ (Dar los números de teléfono)

Si su asma no mejora en _____ días (especificar el número)

_____ (Líneas de instrucciones complementarias)

4. *EMERGENCIA*: pérdida grave del control de su asma

Si tiene una crisis tan grave de ahogo que sólo puede hablar con frases cortas.

Si tiene una crisis grave de ahogo o asma.

Si tiene que utilizar su broncodilatador de rescate o alivio cada 4 horas y no mejora.

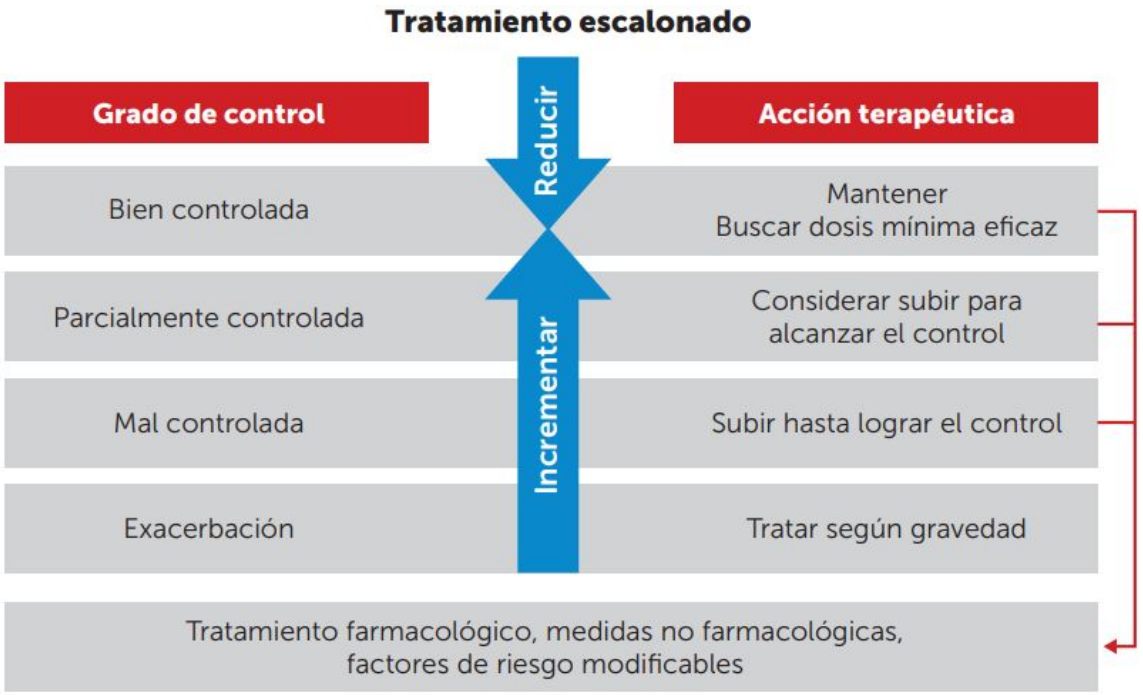
1. Tome de 2 a 4 pulsaciones _____ (broncodilatador de rescate)
2. Tome ____ mg de _____ (glucocorticoides por via oral)
3. Solicite ayuda médica: acuda a _____: Dirección _____: Llame al teléfono _____
4. Continúe usando su _____ (broncodilatador de rescate) hasta que consiga la ayuda médica

Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. GUÍA ESPAÑOLA PARA EL MANEJO DEL ASMA GEMA 5.5 [Internet]. España: Medscape; 2025 [citado el 27 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://gemasma.elmedicointeractivo.com/profesional/

Seguimiento

- 1-3 meses
- Espirometría control a los 3-6 meses

- Control de enfermedad



Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. GUÍA ESPAÑOLA PARA EL MANEJO DEL ASMA GEMA 5.5 [Internet]. España: Medscape; 2025 [citado el 27 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://gemasma.elmedicointeractivo.com/profesional/

Remisión

Tabla 2.8. Resumen basado en el Consenso Español sobre Remisión en Asma (REMAS 2024)[103]

El paciente deberá cumplir todos los requisitos recogidos en cada uno de los niveles descritos.

Remisión en asma	
Remisión clínica	• Asma controlada (ACT ≥ 20). • Sin necesidad de medicación de alivio o rescate. • Sin exacerbaciones y sin necesidad de ciclos de esteroides sistémicos. • Espirometría con FEV_1 ≥ 80%, o en previas, valores > 90% de su mejor valor personal. • Espirometría con prueba broncodilatadora negativa. • Esta situación se debe mantener durante al menos 12 meses, especificando si es con o sin tratamiento.
Remisión completa	• Todos los criterios de remisión clínica. • Sin evidencia de inflamación sistémica o bronquial (FE_{NO} < 40 ppb y eosinófilos esputo < 2%, si se realiza). • Sin hiperrespuesta bronquial. • Sin lesiones de remodelación bronquial en las pruebas de imagen. • Esta situación se debe mantener durante al menos 3 años, especificando si es con o sin tratamiento.

Severidad

Retrospectiva con el control de la enfermedad

STEP 1-2 : LEVE
STEP 3-4: MODERADA
STEP 5 SEVERA

Intermitente, persistente, leve persistente NO USAR

Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. GUÍA ESPAÑOLA PARA EL MANEJO DEL ASMA GEMA 5.5 [Internet]. España: Medscape; 2025 [citado el 27 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://gemasma.elmedicointeractivo.com/profesional/

Exacerbación

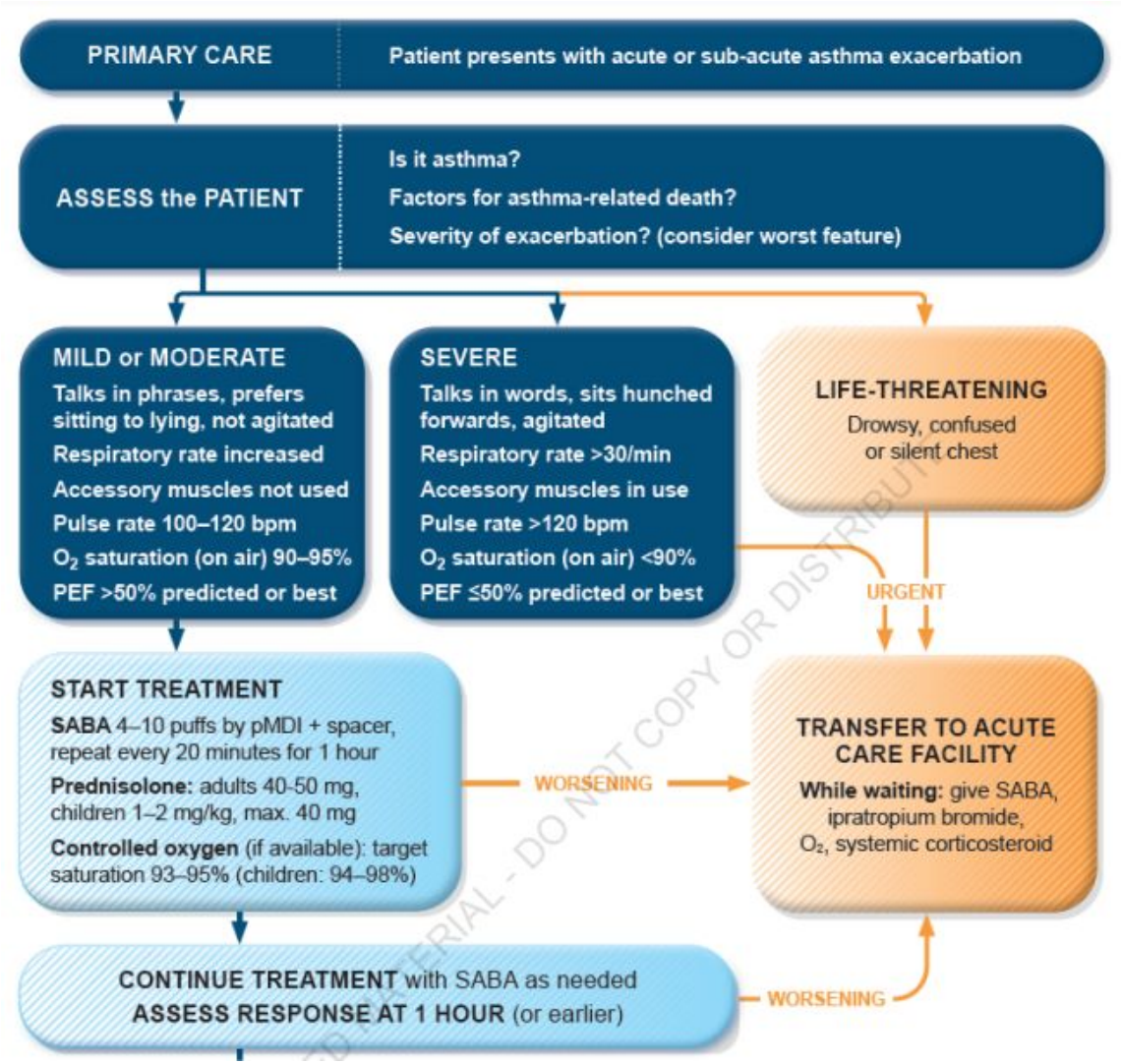
Aumento de sintomatología, con afección en función pulmonar que llevan a un cambio del manejo

Tabla 4.2. Evaluación de la gravedad de la crisis de asma

	Crisis leve	Crisis moderada	Crisis grave	Crisis vital
Disnea	Leve	Moderada	Intensa	Respiración agónica, parada respiratoria
Habla	Párrafos	Frases	Palabras	Ausente
Frecuencia respiratoria (*x'*)	Aumentada	> 20	> 25	Bradipnea, apnea
Frecuencia cardiaca (*x'*)	< 100	> 100	> 120	Bradicardia, parada cardiaca
Presión arterial	Normal	Normal	Normal	Hipotensión
Uso musculatura accesoria	Ausente	Presente	Muy evidente	Movimiento paradójico toracoabdominal, o ausente
Sibilancias	Presentes	Presentes	Presentes	Silencio auscultatorio
Nivel de consciencia	Normal	Normal	Normal	Disminuido o coma
FEV_1 o PEF (valores referencia)	> 70 %	< 70 %	< 50 %	No procede
SaO_2	> 95 %	< 95 %	< 90 %	< 90 %
PaO_2 mm Hg	Normal	< 80 (hipoxemia)	< 60 (insuficiencia respiratoria parcial)	< 60
$PaCO_2$	Normal	< 40	< 40	> 45 (insuficiencia respiratoria hipercápnica)

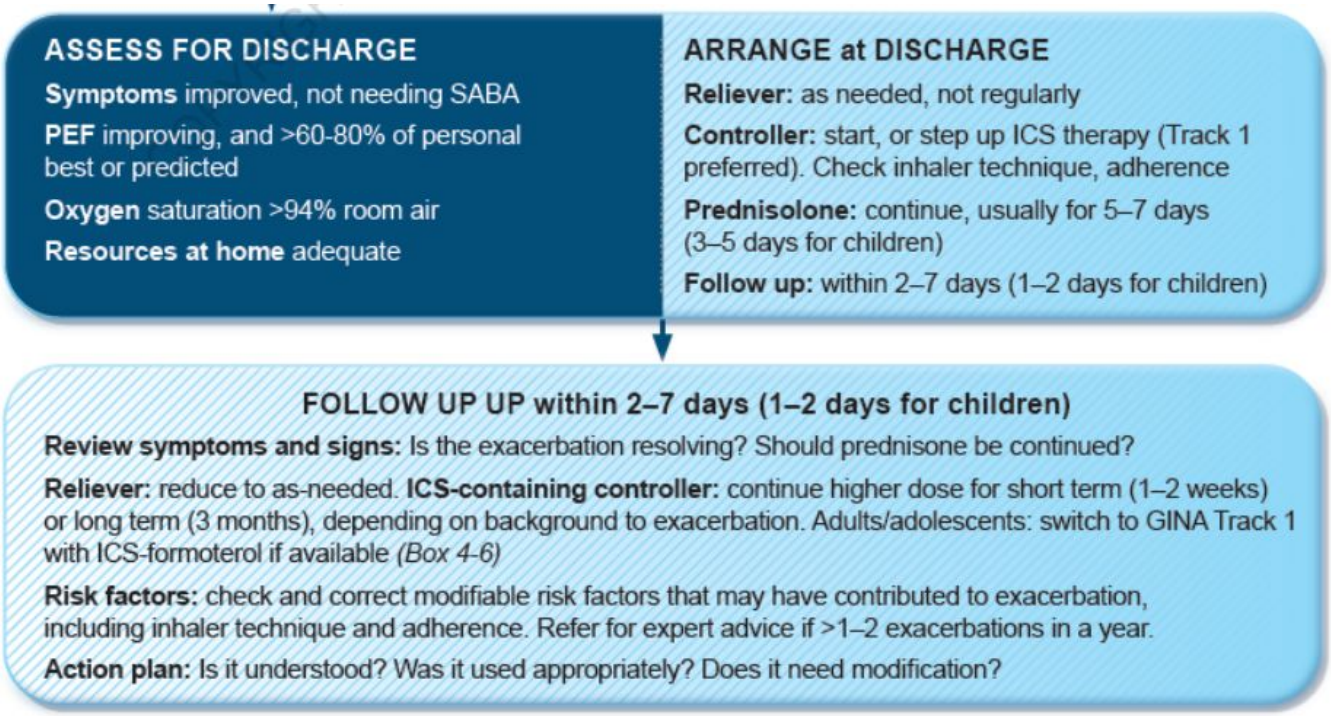
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. GUÍA ESPAÑOLA PARA EL MANEJO DEL ASMA GEMA 5.5 [Internet]. España: Medscape; 2025 [citado el 27 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://gemasma.elmedicointeractivo.com/profesional/

Exacerbaciones

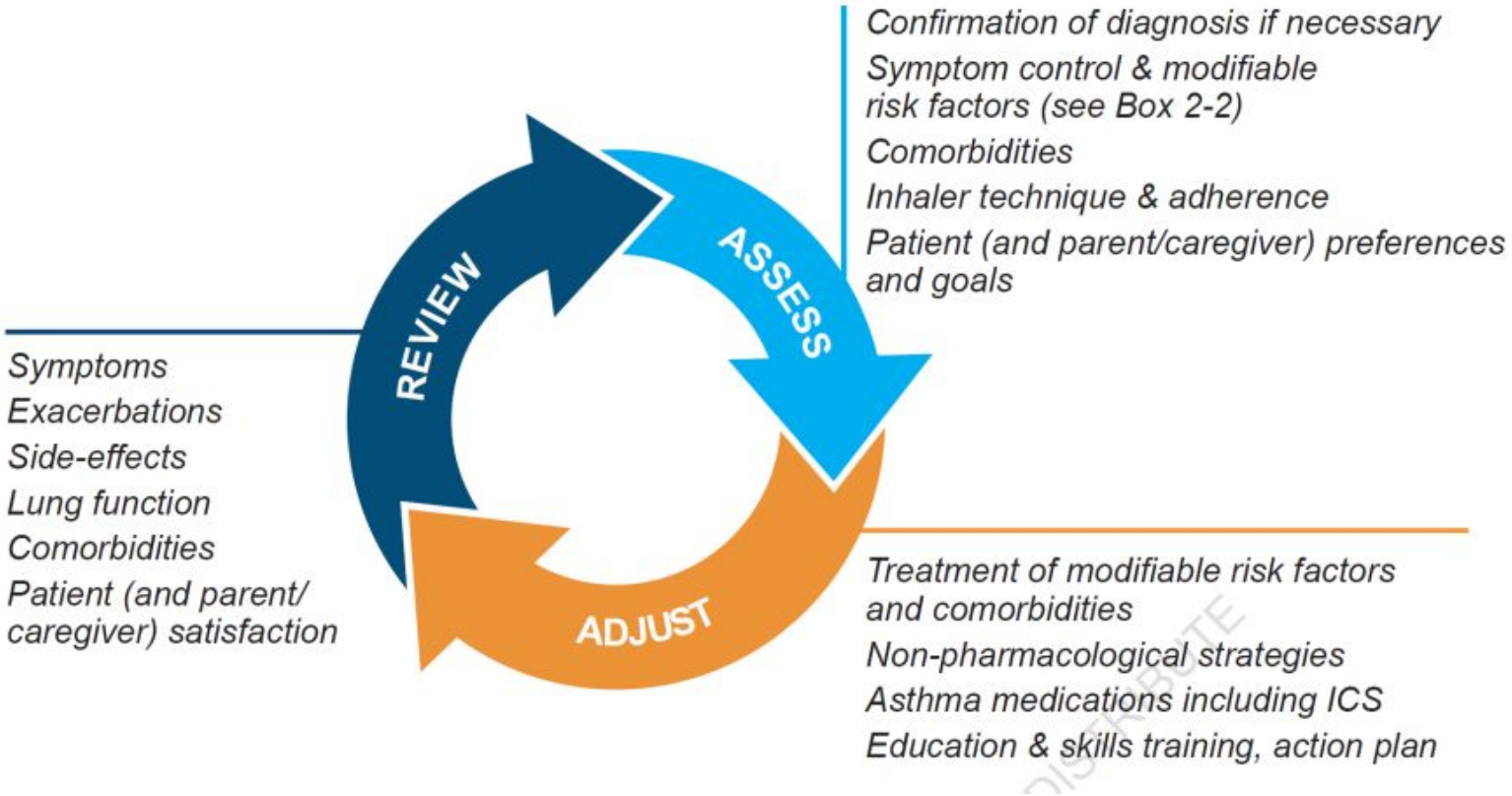


Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention [Internet]. Estados Unidos; 2024 [citado 27 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2024/05/GINA-2024-Strategy-Report-24_05_22_WMS.pdf#page132

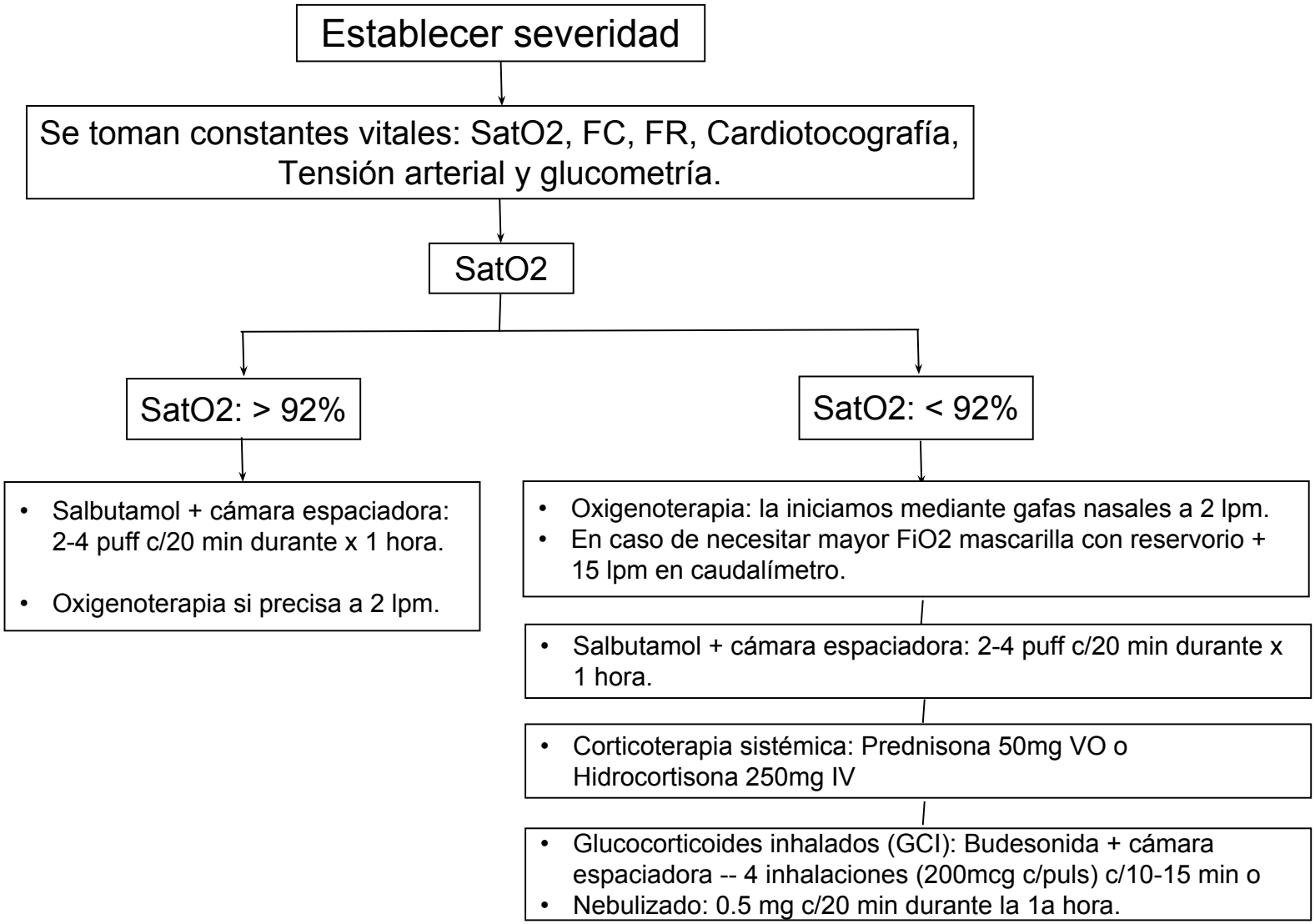
Exacerbaciones



Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention [Internet]. Estados Unidos; 2024 [citado 27 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2024/05/GINA-2024-Strategy-Report-24_05_22_WMS.pdf#page132



Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention [Internet]. Estados Unidos; 2024 [citado 27 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2024/05/GINA-2024-Strategy-Report-24_05_22_WMS.pdf#page132



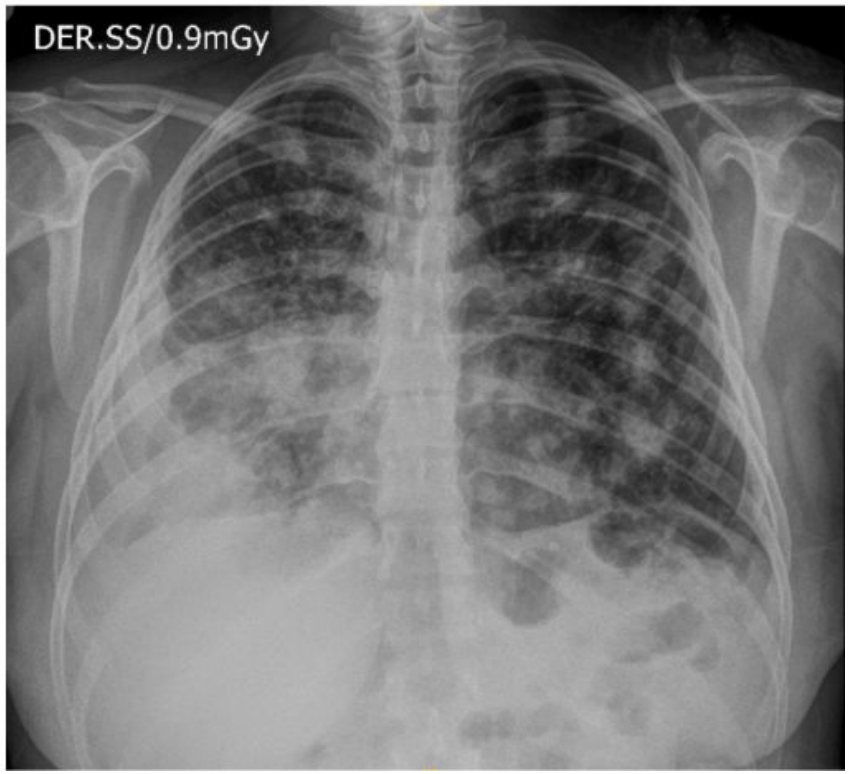
1. Alkourdi A, Villegas J. Patología respiratoria y gestación. Guías asistenciales perinatología. [Internet]. España: Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia; 2023 [Citado el 27 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://sagoandalucia.com/docs/guias/Perinatal/transtornosrespiratoriosyGestacion.pdf

REVALORACIÓN GINECOLOGÍA

REPORTE DE LABORATORIOS

PH 7.46 PCO2 26.2 PO2 75.0
HCO3 19.1 BE -4.8 PO2/FIO 208.2
LAT 1.8

RX DE TÓRAX AP Y LATERAL :
ÁNGULOS COSTOFRÉNICOS CONSERVADOS,CON INFILTRADOS DIFUSOS IMPRESIÓN CONSOLIDACIÓN EN LÓBULO MEDIO



IDX
- G2P1V1
- EMBARAZO DE 31.2 SEMANAS POR ECO
- CRISIS ASMATICA SEVERA ? SOBREINFECTADA
- NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD Q SOFA 1 PUNTO
- RIESGO OBSTÉTRICO ALTO MADRE CON DIAGNÓSTICO DE THAE
RIESGO ISOINMUNIZACIÓN RH NEGATIVO.
RIESGO TROMBOEMBÓLICO BAJO

VALORACIÓN POR GINECOLOGÍA : 8/9/2025 7+00

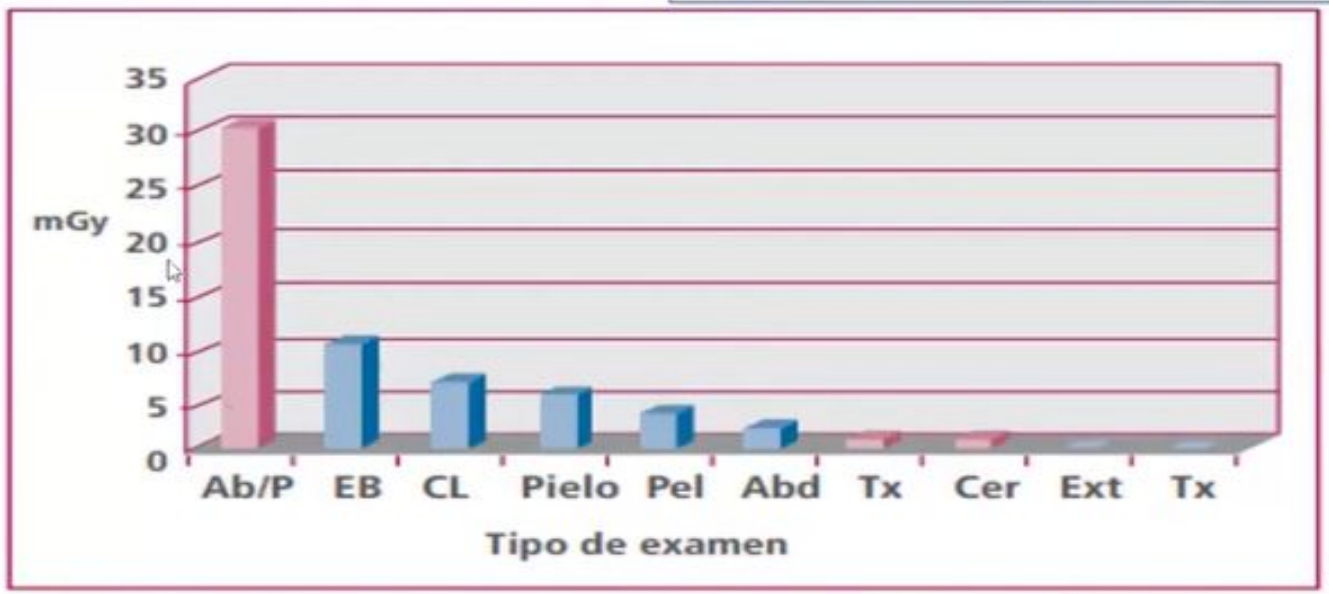
SIGNOS VITALES
TA: 123/76 FR 18 SPO2:98% FC 88 LPM CON RESERVORIO RESPIRATORIO A 4 L/ M
QSOFA 0 PUNTOS MEOWS 1 PUNTO

.. **Se considera por parte de ginecología inicio de manejo antibiótico, manejo con omeprazol y tromboprofilaxis, se explica conducta quien relata entender y aceptar..**

CONSIDERACIONES SOBRE EXPOSICIÓN A RADIACIÓN Y RIESGO DEL FETO

Pneumonia

Antoni Torres[1,2,3,4,5], Catia Cilloniz[1,2,3,4,5], Michael S. Niederman[5], Rosario Menéndez[6], James D. Chalmers[7], Richard G. Wunderink[8] and Tom van der Poll[9]



PERÍODO	EFECTO	DOSIS LÍMITE ESTIMADA
0 – 2 semanas	Ninguno o muerte del embrión	50 – 100 mGy
2 – 8 semanas	Anomalías congénitas, retardo de crecimiento	200 – 250 mGy
8 – 15 semanas	Retardo mental severo, microcefalia	60 – 310 mGy
16 – 25 semanas	Retardo mental severo	250 – 280 mGy

Cortés JA, Cuervo-Maldonado SI, Nocua-Báez LC, Valderrama MC, Sánchez EA, Saavedra A, et al. [Guía de práctica clínica para el manejo de la neumonía adquirida en la comunidad]. Rev. Fac. Med. 2022;70(2):e93814. English. doi: https:// doi.org/10.15446/revfacmed.v70n2.93814.

NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD

- Representa el 4,2 % de los ingresos preparto por complicaciones no obstétricas.
- 20 a 50% en pacientes que requieren ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI)

MORTALIDAD

Bacteriemia, ingreso en la UCI, comorbilidades (especialmente enfermedad neurológica) e infección con un patógeno potencialmente resistente a múltiples fármacos (p. ej., Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacteriaceae).

Microorganismo	n * 76 (46) %	n* 311 (47) %	n* 138 (48) %	n+ 48 (49) %	n++ 66 (50) %
Bacterias					
Streptococcus pneumoniae	36	27.6	16	23.4	12.5
Staphylococcus aureus	2	2.6	2.17	6.4	2.1
Staphylococcus spp. coagulasa negativos		2.2	1.45	2.13	4.2
Haemophilus influenzae	10	2.2	1.45	2.13	4.2
Enterobacteriacea	3.5	3.5	2.9	14.9	6.2
Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumanii		1		4.26	4.2
Bacterias atípicas					
Moraxella catarrhalis		0.3			
Mycoplasma pneumoniae	22	13.8		8.56	12.5
Legionella pneumophila		1.9	2.9	2.13	2.1
Coxiella burnetii		5.8		2.13	4.2
Chlamydophila pneumoniae	1.3	8.7		2.13	4.2
Virus					
Virus influenza A y B		10	1.9	10.6	16.7
Adenovirus		7.1		8.51	10.4
Virus sincitial respiratorio		4.2	0.72	8.51	6.2
Virus parainfluenza 1, 2 y 3		1.9	0.72	8.13	2.1
Micobacterias					
Mycobacterium tuberculosis		2.9	0.72		
Otros					
Etiología mixta		22.8	8.7	19.7	20.8
Etiología desconocida	31.5	34	55.8	48.5	33.3

NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD

Vías de infección

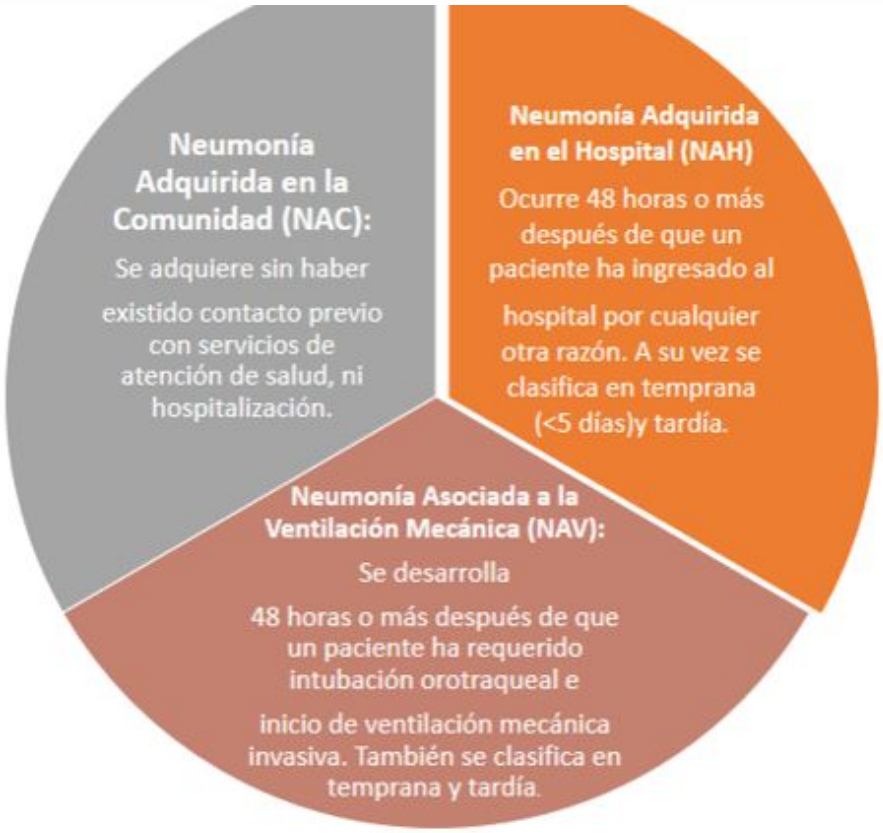
- Más común: microaspiración de patógenos en el aire o secreciones orofaríngeas
- Aspiración de ácido gástrico (neumonitis por aspiración), alimentos o líquidos
- Diseminación hematógena (raro)

NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD NAC

- Paciente ambulatorio
- < 48 horas desde el ingreso hospitalario
- > 7 días desde el egreso hospitalario

NEUMONÍA ADQUIRIDA EN EL HOSPITAL

- >48 horas desde el ingreso hospitalario.
- < 7 días desde el egreso hospitalario



Cortés JA, Cuervo-Maldonado SI, Nocua-Báez LC, Valderrama MC, Sánchez EA, Saavedra A, et al. [Guía de práctica clínica para el manejo de la neumonía adquirida en la comunidad]. Rev. Fac. Med. 2022;70(2):e93814. English. doi: https:// doi.org/10.15446/revfacmed.v70n2.93814.

CLASIFICACIÓN

–C: confusión

–U: urea > 7mmol/l (urea=BUN x 2,14) o en el sistema americano, urea > 44mg/dl o BUN > 19mg/dl

–R: frecuencia respiratoria ≥ 30por minuto

–B: Presión arterial sistólica < 90mmHg

–Presión arterial diastólica ≤ 60mmHg

–65: edad ≥65años

Neumonía adquirida en la comunidad

Es una causa importante de morbilidad y mortalidad en pacientes de todas las edades

Se propone, clasificar la neumonía adquirida en la comunidad en 3 grupos, así:

- ***Grupo I:*** puntajes 0 y 1; mortalidad, 1,5%
- ***Grupo II:*** puntaje de 2; mortalidad, 9,2%
- ***Grupo III:*** puntaje igual a 3 o mayor; mortalidad, 22%; neumonía grave

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN



1)Edad de 65 años o mayor: por sí sola no es un criterio de hospitalización.

2)Presencia de enfermedades concomitantes.

3)Hospitalización en el último año.

4)Hallazgos físicos: FR> 30por minuto, PD< 60mmHg o PS< 90mmHg, FC125por minuto, T° < 35°C o > 40°C, estado de conciencia alterado y evidencia de infección extrapulmonar.

5)Hallazgos de laboratorio: leucocitos de menos de 4.000 o más de 30.000células por mm^3 y neutrófilos de menos de 1.000células por mm^3; PaO2 < 60mmHg o PaCO2 > 50mmHg (a nivel del mar); creatinina > 1,2mg/dl o BUN >20 mg/dl; hematocrito < 30% o hemoglobina < 9mg/dl; evidencia de sepsis o disfunción orgánica, acidosis metabólica (pH<7,35) o coagulación intravascular diseminada.

6)Hallazgos radiográficos como compromiso multilobar, presencia de neumatoceles y de derrame pleural.

CRITERIOS MAYORES Y MENORES - UCI

Criterios de la American Thoraci Society/Infectious Diseases Society of America para admisión en unidad de cuidado intensivo.

Criterios mayores	Criterios menores (mínimo 3)
Necesidad de respiración mecánica asistida	Frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto
Soporte vasopresor	PaFiO2 < 250
	Infiltrados multilobares
	Confusión
	BUN > 20 mg/dl
	Leucopenia < 4.000 células/mm^3
	Trombocitopenia < 100.000 células/mm^3
	Hipotermia < 36 °C
	Hipotensión que requiere alto aporte de líquidos

Ashby T, Staiano P, Najjar N, Louis M. Bacterial pneumonia infection in pregnancy. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol*. 2022 Dec;85(Pt A):26-33. doi:10.1016/j.bpobgyn.2022.07.001

No.	Recomendación	Nivel de Evidencia
1	Para pacientes con los siguientes síntomas y signos clínicos de infección respiratoria aguda, se recomienda realización de radiografía de tórax para Realizar el diagnóstico de Neumonía: (fiebre o malestar general con tos o expectoración) y alguno de los siguientes criterios: frecuencia cardíaca > 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria > 30 por minuto, temperatura oral de 38 °C o más o anormalidades a la auscultación del tórax (estertores, egofonía, frémito u otros hallazgos de consolidación o de derrame pleural)	Recomendación Fuerte Calidad de la evidencia Moderada (IIB)
2	Se recomienda la toma de los siguientes paraclínicos a todos los pacientes con sospecha de neumonía : Hemograma completo, evaluación de la función renal (incluyendo concentración de electrolitos séricos), pruebas de función hepática, glucemia y medición de saturación de oxígeno. Monitorizaciòn fetal en cas de embarazo> 24 semanas	Recomendación Fuerte Calidad de la evidencia Moderada (IIB)
3	Se recomienda realizar pruebas microbiológicas en todos los pacientes con Neumonía severa a su ingreso a UCI	Recomendación débil Nivel de evidencia Baja (D)
4	Se recomienda la toma de hemocultivos a todos los pacientes que ingresan a UCI con neumonía severa, preferiblemente antes del inicio de antibióticos	Recomendación débil nivel de eviencia baja (D)
5	Se recomienda la toma de pruebas de secreción orotraqueal para estudio microbiológico de gram y cultivo a todos los pacientes que ingresen a UCI	Recomendación Debil nivel de evidencia Moderado (B)

INTERCONSULTA MEDICINA INTERNA
08/09/2025 (9+30 AM)

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA
- CRISIS ASMÁTICA SEVERA PERSISTENTE
- NEUMONÍA MULTILOBAR ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB65 0 PTOS ATS/IDSA 3 CRITERIOS MENORES
- G2P1V1
- EMBARAZO DE 31.2 SEMANAS POR ECO
- DESCARTAR INFECCIÓN ACTIVA POR SARS COV 2

TRASLADO A UCI INTERMEDIO
HOSPITALIZAR EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA.
MONITORIZACIÓN CONTINUA CABECERA 45 °
MÁSCARA DE NOREINHALACIÓN >95%
LR 100 CC/ H
OMEPRAZOL 40 MG IV CADA DIA
AMPICILINA SULBACTAM 3 GR IV CADA 6 HORAS
CLARITROMICINA 500MG ORAL CADA 12 HORAS
MNB CON BERODUAL 20 GOTAS + 3 CC SSN CADA 4 HRS
HIDROCORTISONA 50 MG IV CADA 12 HORAS
ENOXAPARINA 40MG SC CADA DIA TERAPIA RESPIRATORIA CADA 8 HORAS
CURVA TÉRMICA CADA 4 HRS
VIGILAR PATRÓN RESPIRATORIO

07/09/2025 - 19+42
HEMOGRAMA
Recuento de Leucocitos 9.87 x10e3/uL
Neutrofilos 75.1 %
Linfocitos 20.0 %
Monocitos 4.6 %
Eosinofilos 0.3 %
Basofilos 0.0 %
Recuento de Eritrocitos 5.31 x10e6/uL
Hemoglobina 15.6 g/dL
Hematocrito 46.9 %
Volumen Corpuscular Medio 88.3
HB Corpuscular Media 29.5 pg
Concentración HB Corpuscular Media 33.4 g/dL
Ancho Distribución Eritrocitaria (IDE-CV) 12.9 %
Recuento de Plaquetas 257 x10e3/uL
Volumen Plaquetario Medio 9.6 fL
Indice de Distribución Plaquetario (IDP) 15.9 um3 -
Plaquetocrito (PCT) 0.245 % 0.15 - 0.50

GASES ARTERIALES: PH 7.46 PCO2 26.2 PO2 75.0 HCO3 19.1 BE -4.8 PO2/FIO 208.2 LAT 1.8

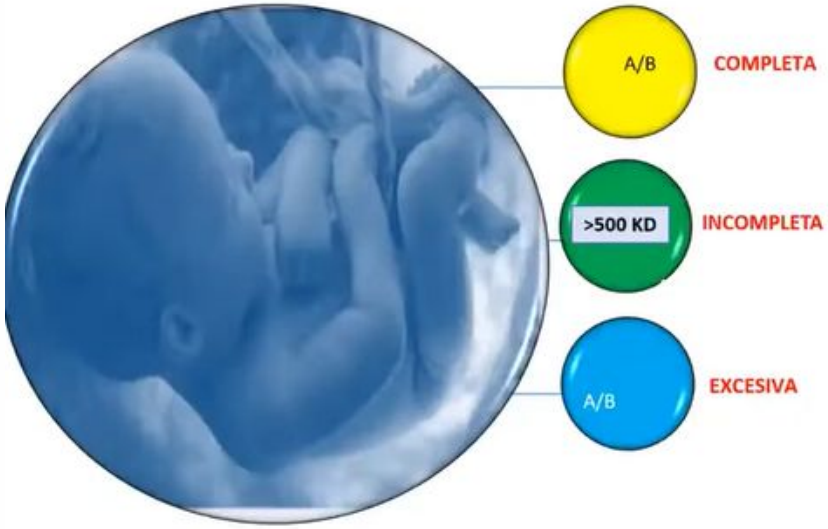
Situación clínica	Tratamiento antibiótico recomendado	Alternativas	Notas especiales	Duración
NAC leve (ambulatoria, sin comorbilidades)	- Monoterapia con macrólidos (azitromicina, claritromicina) - Amoxicilina o amoxicilina/clavulánico + azitromicina	Si alergia a betalactámicos: clindamicina	Revisar resistencia local. Puede requerir dosis más altas por ↑ aclaramiento renal.	5–7 días
NAC leve con comorbilidades (diabetes, cardiopatía, enfermedad pulmonar, renal o hepática)	Amoxicilina/clavulánico + macrólido	Fluoroquinolona respiratoria (levofloxacino o moxifloxacino) en casos seleccionados	Uso de fluoroquinolonas controvertido; metaanálisis recientes: bajo riesgo fetal.	5–7 días
NAC por Legionella	Azitromicina o eritromicina	—	Diagnóstico con antígeno urinario. Puede causar cuadro crítico.	14 días

Ashby T, Staiano P, Najjar N, Louis M. Bacterial pneumonia infection in pregnancy. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol*. 2022 Dec;85(Pt A):26-33. doi:10.1016/j.bpobgyn.2022.07.001

NAC grave (hospitalizada, no UCI)	Betalactámico antineumocócico (ceftriaxona, cefotaxima, ampicilina/sulbactam) + azitromicina	Si alergia: clindamicina + aztreonam Añadir vancomicina si sospecha de SARM	Manejo igual que población general.	5–7 días
NAC grave con sepsis/choque séptico	Igual esquema de grave + soporte hemodinámico	Norepinefrina como vasopresor de elección	Monitoreo fetal ≥24 sem. Corticoides prenatales >23 sem. Líquidos IV juiciosos (≤1–2 L). Consultar Maternofetal/Obstetricia.	Según evolución
Neumonía nosocomial	Betalactámicos de amplio espectro ± cobertura antipseudomónica y anti-SARM según riesgo	—	Ajustar a antibiograma local y seguridad en embarazo.	Según germen y evolución

Ashby T, Staiano P, Najjar N, Louis M. Bacterial pneumonia infection in pregnancy. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol*. 2022 Dec;85(Pt A):26-33. doi:10.1016/j.bpobgyn.2022.07.001

COMO SE DA LA TRANSFERENCIA PLACENTARIA DE A/B?



- **Peso Antibiótico**
- **Velocidad de filtración**
- **Unión a proteínas**
- **% ionización A/B**
- **Tasa de excreción.**
- **Trimestre del embarazo.**

TODOS LOS ANTIBIOTICOS CRUZAN LA BARRERA PLACENTARIA

Antibiótico	Dosis
Claritromicina	500 mg IV ó VO cada 12 horas
Azitromicina	500 mg VO cada 12 horas
Ampicilina Sulbactam	3 gramos IV cada 6-8 horas
Piperazilina Tazobactam	4.5 gramos IV cada 8 horas
Levofloxacina	500 mg IV ó VO cada 24 horas
Moxifloxacina	400 mg IV ó VO cada 24 horas

Grupo de riesgo	Esquema de elección	Alternativa
Grupo 1	Macrólido	Quinolona respiratoria
Grupo 2	Beta lactámico más macrólido	Quinolona respiratoria
Sospecha S. aureus	Linezolid o Vancomicina	
Sospecha Pseudomona	Piperazililina-tazobactam o cefepime más amikacina más macrólido	

INGRESO A UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 08/09/2025

EXAMEN FÍSICO:
PACIENTE EN MAL ESTADO GENERAL CON MARCADA DIFICULTAD RESPIRATORIA, TAQUIPNEIA, AGITADA.

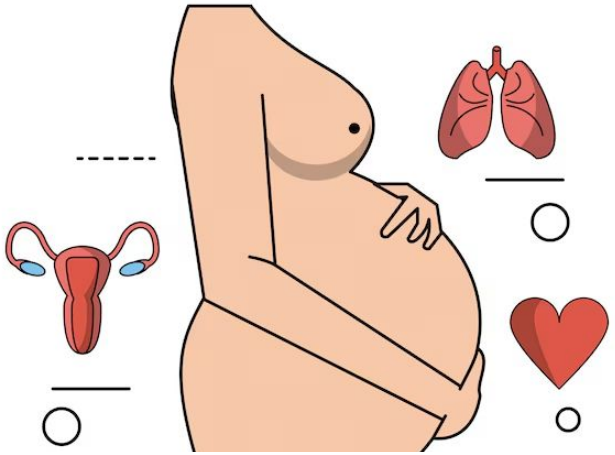
- DISCURSO ENTRECORTADO SOLO LOGRANDO EMITIR UNA O DOS PALABRAS.
- GRAVES SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, ESFUERZO MUSCULAR Y TIRAJES SUBCOSTALES
- MURMULLO VESICULAR BIBASAL DISMINUIDO CON ESTERTORES GENERALIZADOS

GASES ARTERIALES: 08/09/2025 05:00 AM PH 7.46 PCO2 26.2 PO2 75.0 HCO3 19.1 BE -4.8 PO2/FIO 208.2, LACT 1.8 ALCALOSIS RESPIRATORIA COMPENSADA CON TRASTORNO LEVE DE LA OXIGENACIÓN SIN HIPERLACTATEMIA
08/09/2025 12:00 AM (7 HORAS DESPUÉS) : PH 7.43 PCO2 27 PO2 73 HCO3 18 BE -5.6 PO2/FIO 132, LACT 2.7 EQUILIBRIO ACIDO BASE CON TRASTORNO MODERADO DE LA OXIGENACIÓN CON HIPERLACTATEMIA

PACIENTE FEMENINA DE 27 AÑOS DE EDAD CON GESTACIÓN DE 31 SEMANAS QUIEN INGRESA POR CUADRO DE DIFICULTAD RESPIRATORIA Y RADIOGRAFÍA DE TÓRAX CON INFILTRADOS EN LOS CUATRO CUADRANTES, SE REVISAN IMAGENES CON UN GRAVE COMPROMISO DEL PARÉNQUIMA PULMONAR GENERALIZADO, LA GASOMETRÍA ARTERIAL MUESTRA UN RAPIDO Y PROGRESIVO DETERIORO DE LA FUNCIÓN PULMONAR EN POCAS HORAS , AL EXAMEN FÍSICO ENCUENTRO UNA PACIENTE CON SIGNOS DE INMINENCIA DE FRACASO RESPIRATORIO POR LO CUAL BAJO SECUENCIA DE INDUCCION RAPIDA SE REALIZA INTUBACION OROTRAQUEAL, SE REALIZA LARINGOSCOPIA (CORMACK III), SE INTRODUCE TUBO OROTRAQUEAL NUMERO 7.5 Y SE FIJA A LA COMISURA LABIAL A 23 CM, SE COMPRUEBA ADECUADO POSICIONAMIENTO CON AUSCULTACIÓN Y CURVAS DE VENTILACIÓN MECANICA, SE REALIZA MEDICION DE MECANICA VENTILATORIA ENCONTRANDO UNA GRAVE DISMINUCION DE LAS COMPLACENCIAS PULMONARES, CON ELASTANCIA ELEVADA, SIN EMBARGO CON ADECUADA RESPUESTA A UNA MANIOBRA DE RECLUTAMIENTO ALVEOLAR, SE REALIZA TITULACIÓN DE PEEP BASADO EN LA MEJOR COMPLACENCIA ENCONTRANDO EN 10 EL MEJOR VALOR, POR EL MOMENTO DEBIDO A UN ACOPLE VENTILATORIO DIFICULTOSO SE DECIDE INICIO DE INFUSION DE RELAJANTE MUSCULAR Y POSTERIOR A UN ADECVUADO ACOPLE SE REALIZARA CONTROL GASOMETRICO EN DOS HORAS PARA DETERMINAR SI REQUIERE VENTILACION EN DECUBITO PRONO. EN EL ASPECTO CARDIOVASCULAR LA PACIENTE MUESTRA TENSIONES ARTERIALES CON TENDENCIA AL ALZA, EL LACTATO ARTERIAL TOMADO EN GASES PREVIOS MUESTRA UN AUMENTO EN PROBABLE RELACION CON FATIGA MUSCULAR, POR EL MOMENTO NO HAY REQUERIMIENTO DE SOPORTE VASOPRESOR, SE INDICA CAMBIO PERIODICO DE POSICION PRIORIZANDO DECUBITO LATERAL IZQUIERDO. A LA VALORACION DEL BINOMIO MATERNO FETAL SE REALIZARA MANEJO CONJUNTO CON EL SERVICIO DE GINECOLOGIA, SE PLANTEA LA REALIZACION DE MONITORIAS FETALES CADA 12 HORAS Y EL DIA DE HOY UNA ECO OBSTÉTRICA PARA EVALUACION DE BIENESTAR FETAL, EN EL MOMENTO NO HAY INDICACIÓN PARA INTERRUPCIÓN DE LA GESTACIÓN YA QUE ESTA NO GENERA EN EL MOMENTO EMPEORAMIENTO DE LA FUNCIÓN CARDIOVASCULA, NI RESPIRATORIA POR LO CUAL HASTA EL MOMENTO CONTINUAREMOS CON TODOS LOS ESFUERZOS QUE ORIENTEN AL MANTENIMIENTO DEL BIENESTAR MATERNO FETAL, DEBIDO A QUE LA PACIENTE RECIBE DOSIS ALTAS DE ESTEROIDES ENDOVENOSOS NO REQUIERE DOSIS ADICIONALES PARA MADURACIÓN PULMONAR. SE SOLICITA REALIZACION DE JUNTA MEDICA ENTRE LOS SERVICIOS DE GINECOLOGÍA, PEDIATRÍA Y CUIDADO INTENSIVO. LA FUNCIÓN RENAL Y EL GASTO URINARIO SON NORMALES, DESDE EL PUNTO DE VISTA INFECTOLOGICO SE TOMAN CULTIVOS DE SANGRE, SECRECIONES RESPIRATORIAS, SE SOLICITA PANEL VIRAL Y PRUEBA DE COVID, ASI COMO PANEL DE DETECCION MOLECULAR DE MULTIPLES PATOGENOS EN SECRECIONES RESPIRATORIAS DADA LA PRESENTACION PROLONGADA EN EL TIEMPO, AUSENCIA DE RESPUESTA INFLAMATORIA GRAVE EN ESTA PACIENTE Y EL USO PROLONGADO DE ESTEROIDES DE FORMA DIARIA POR SU ANTECEDENTE DE ASMA. , SE SOLICITA CONCEPTO POR INFECTOLOGÍA CON QUIENES SE DECIDE AMPLIAR COBERTURA PARA PSEUDOMONA CON CEFEPIME.

DECÚBITO PRONO EN SRDA

- Disminuye la mortalidad y mejora la oxigenación durante la ventilación mecánica.
- Indicada en pacientes con una relación entre la presión parcial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno (PaO_2 /FiO_2) inferior a 150 mmHg



> Consumo de O2 = SaO2 (>95%); PaO2 (>70 mmHg) asegurando oxigenación fetal.

- Aumento de la homogeneidad de la ventilación y la perfusión pulmonar
- Alivio de la compresión alveolar en las regiones pulmonares dorsales
- Modificación de la distensibilidad torácica, lo que mejora la distribución de gases hacia los pulmones ventrales y paradiafragmáticos.

IMPACTO DE LA POSICIÓN EN PRONO SE DETERMINA CUANDO EL PACIENTE REGRESA A POSICIÓN EN SUPINO

https://doi.org/10.3390/vaccines10122182

NOTA RETROSPECTIVA 08/09/2025 (17+30)

DESDE EL PUNTO DE VISTA VENTILATORIO LA PACIENTE MUESTRA UN CONTROL DE GASOMETRÍA ARTERIAL QUE EVIDENCIA UNA MEJORÍA LEVE N LA FUNCIÓN PULMONAR SIN EMBARGO CON UNA GRAVE ACIDOSIS RESPIRATORIA POR LO CUAL SE REALIZA PASO A MODO APRV COMO RESCATE
EN EL ASPECTO CARDIOVASCULAR LA PACIENTE MUESTRA TENSIONES ARTERIALES NORMALES A LA VALORACIÓN DEL BINOMIO MATERNO FETAL EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA, REALIZA EVALUACIÓN ECOGRÁFICA DE BIENESTAR FETAL EL CUAL ES DESFAVORABLE POR LO CUAL SE DECIDE PASAR A SALAS DE CIRUGÍA PARA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO DE FORMA URGENTE POR LO CUAL SE ACTIVA CÓDIGO DE RESPUESTA RÁPIDA. LA FUNCIÓN RENAL Y EL GASTO URINARIO SON NORMALES. DESDE EL PUNTO DE VISTA INFECTOLÓGICO SE RECIBE REPORTE DE LAS PRUEBAS MOLECULARES LAS CUALES REPORTAN POSITIVIDAD PARA RINOVIRUS, POR EL MOMENTO NO SE REALIZAN CAMBIOS DEBIDO A QUE NO EXISTE MANEJO ESPECÍFICO PARA ESTO, CONTINUAREMOS CON LAS MEDIDAS DE SOPORTE INSTAURADAS. SE TRASLADA PACIENTE A SALAS DE CIRUGÍA EN LAS CONDICIONES DESCRITAS, CONTINUARA EN UCI PARA CONTROL POSTOPERATORIO.

INFLUENZA A Antígeno NEGATIVO
. INFLUENZA B Antígeno NEGATIVO
ADENOVIRUS: NEGATIVO
MICROSCOPIA GRAM Cocos Gram Positivos +
CULTIVO DE GÉRMENES COMUNES
CRECIMIENTO DE MICROBIOTA HABITUAL

Listado de estudios:

- ECOGRAFÍA

Descripcion del procedimiento

*** ECOGRAFIA OBSTETRICA TRANSABDOMINAL
BIOMETRIA:
Ver Anexo.
DBP:78.6 mm para 32 semanas0 días
CC: 277 mm para 30 semanas 2 días
CA: 260 mm para 30 semanas 1 días
LF: 57 mm para 30 semanas0 días
PEF 1546 gr
P: 12
HALLAZGOS
Feto único vivo, en situación longitudinal, presentación cefálico dorso izquierdo.
Placenta corporal anterior G II/III, de 31 mm de espesor. Cordón umbilical de tres vasos.
Líquido amniótico normal 11.1cm.
Cráneo: Estructuras intracraneanas normales. Cara: labio superior íntegro.
Cuello: normal. Columna vertebral: íntegra Tórax: normal.
Corazón: Situs solitus, corte de cuatro cámaras normal. FCF 140 lpm.
Abdomen: Pared anterior y diafragma íntegros. Hígado normal. Cámara gástrica, riñones y presentes normales. No se observa patología intestinal. Ecogenicidad abdominal normal.
Extremidades: morfología y movilidad normales.

OPINIÓN:
EMBARAZO DE 30 SEMANAS 0 DIAS POR BIOMETRIA FETAL.
DESACELERACION EN CURVA DE CRECIMIENTO FETAL

ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA CON PERFIL BIOFÍSICO

Feto único vivo en situación longitudinal cefálico dorso izquierdo FCF: 140 lat/min.
Placenta corporal posterior grado III/III de maduración de 31 mm de espesor.

Movimientos Fetales	0	
Movimientos Respiratorios	0	
Tono Fetal	0	
Líquido amniótico	2	
Perfil biofisico		2/8

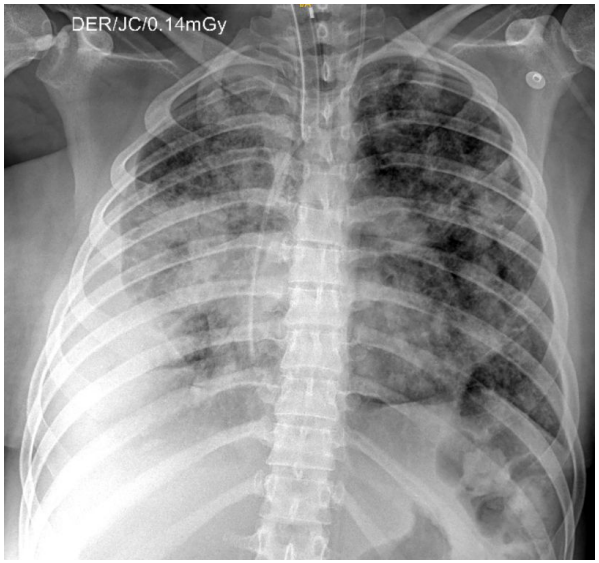
ILA: 11 cm

PERFIL BIOFÍSICO: 2/8

08/09/2025 17+30

**NOTA GINECOLOGÍA
PACIENTE DE 27 AÑOS G2P1V1 CON EMBARAZO DE 31.2 SEMANAS HOSPITALIZADA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS POR SÍNDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO SEVERO DEL ADULTO Y NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD -CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA Y ASMA PERSISTENTE MODERADA/GRAVE A **QUIEN SE LE REALIZA PERFIL BIOFÍSICO** CON 2/8. POR ILA NO SE EVIDENCIAN MOVIMIENTOS FETALES NI RESPIRATORIOS NI TONO FETAL , FETOCARDIA EN 140 ,SE CONSIDERA DADO EL RÁPIDO DETERIORO DE LA PACIENTE CON LOS ALTOS REQUERIMIENTOS VENTILATORIOS Y LA PERSISTENCIA DE LA ACIDOSIS ASOCIADO AL PERFIL BIOFÍSICO 2/8 FINALIZACIÓN DE LA GESTACIÓN POR VÍA ALTA **SE ACTIVA EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA OBSTÉTRICA PARA FINALIZACIÓN DE LA GESTACIÓN POR VÍA ALTA** , SE AVISA A SALAS DE CIRUGÍA Y PEDIATRÍA , SE TOMA DECISIÓN EN CONJUNTO CON UCI , EN EL MOMENTO NO HAY FAMILIAR PARA DAR INFORMACIÓN ***

NOTA RETROSPECTIVA 09/09/2025



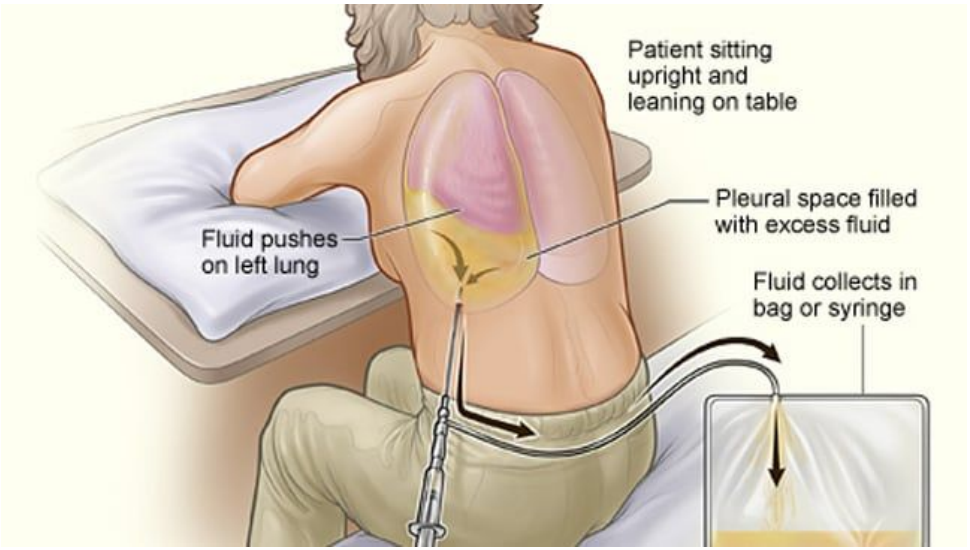
OPACIDADES DE OCUPACIÓN ALVEOLAR MULTILOBARES BILATERALES CON TENDENCIA A LA CONSOLIDACIÓN. OBLITERACIÓN DEL RECESO COSTOFRÉNICO DERECHO QUE SUGIERE DERRAME PLEURAL. ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNA.

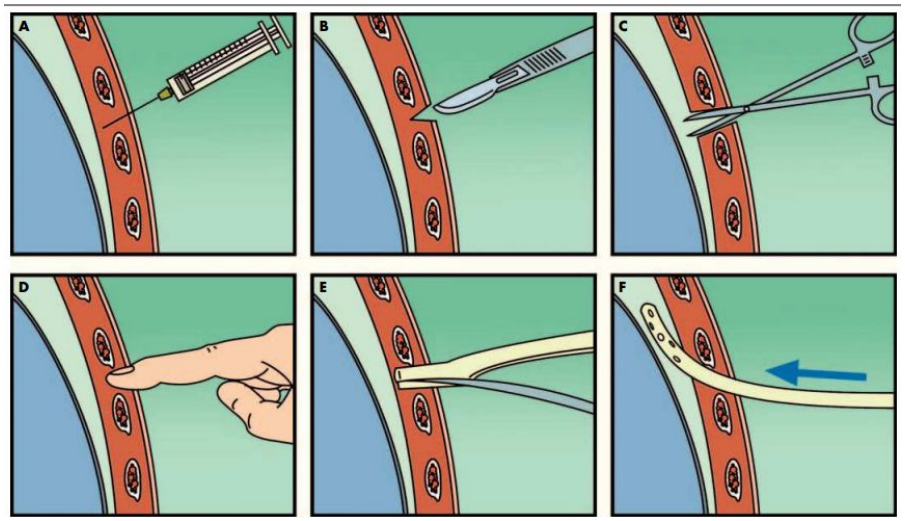


NEUMOTÓRAX DERECHO CON UNA DISTANCIA INTERPLEURAL DE 46 MM A NIVEL DEL HILIO PULMONAR. OPACIDADES MIXTAS DIFUSAS EN AMBOS HEMITÓRAX. SILUETA CARDIACA DE TAMAÑO NORMAL. OBLITERACIÓN DE LOS SENOS COSTOFRÉNICOS DE FORMA BILATERAL, HALLAZGO EN PROBABLE RELACIÓN CON DERRAMES PLEURALES

UN PACIENTE HOSPITALIZADO EN LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO POR UN SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO SEVERO DEL ADULTO CON REQUERIMIENTO DE VENTILACIÓN EN DECÚBITO PRONO POR HIPOXEMIA REFRACTARIA. SE REVISA EL DÍA DE HOY LA RADIOGRAFÍA DE TÓRAX EN LA CUAL SE EVIDENCIA UN IMPORTANTE DERRAME DEL HEMITÓRAX DERECHO CON UN COMPONENTE COMPRESIVO SOBRE EL PARÉNQUIMA PULMONAR. SE EVIDENCIA UNA COLECCIÓN DE ASPECTO HETEROGÉNEO DE DIFÍCIL CARACTERIZACIÓN, MOTIVO POR LA CUAL SE DECIDE BAJO GUÍA ECOGRÁFICA REALIZAR UNA TORACENTESIS DIAGNÓSTICA. EN LA LÍNEA AXILAR POSTERIOR ENTRE EL DÉCIMO Y ONCEAVO ESPACIO INTERCOSTAL Y BAJO GUÍA ECOGRÁFICA SE REALIZA UNA PUNCIÓN CON AGUJA DE 20 CENTÍMETROS, CORRECCIÓN JERINGA DE 20 CENTÍMETROS Y AGUJA DE 3 CENTÍMETROS DE LONGITUD. SE OBTIENE SALIDA DE LÍQUIDO CLARO CON ALGUNOS GRÁNULOS SANGUINOLENTOS, EL CUAL SE ENVÍA PARA ESTUDIO. POSTERIOR A ESTO, LA PACIENTE PRESENTA DESATURACIÓN Y REQUERIMIENTO DE AUMENTO DE LA FRACCIÓN INSPIRADA DE OXÍGENO, POR LO CUAL SE SOLICITA UNA RADIOGRAFÍA DE TÓRAX URGENTE. AL ANÁLISIS DE LA MISMA SE EVIDENCIA UNA CÁMARA DE NEUMOTÓRAX DERECHO CON COMPROMISO DE APROXIMADAMENTE 30 Y 40% DE ESTE HEMITÓRAX. POR ESTA RAZÓN SE SOLICITA VALORACIÓN URGENTE POR EL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL PARA INSERCIÓN DE TÓRACOSTOMÍA DE DRENAJE.

TORACOCENTESIS Y TORACOSTOMÍA





EVOLUCIÓN DIA 09/09/2025 Y 10/09/2025

09/09/2025 : GASES ARTERIALES: PH: 7.16 , PCO2: 46 , PO2: 70 , HCO3: 16.8 , PAFI : 233 , SAT: 88%, LAC 5.9 , BE : - 12 , HB : 17.4 ACIDOSIS METABOLICA
09/09/2025 : GASES ARTERIALES: PH: 7.39 , PCO2_ 33, PO2. 78 , HCO3: 21 PAFI: 262, SATO2: 95%, LAC: 1.4 , BE - 4.0, HB: 14 //
09/09/2025 GASES ARTERIALS: PH: 7.34 , PCO2_ 43 , PO2. 71 , HCO3: 23 PAFI: 205 , SATO2: 95%, LAC: 1.4 , BE - 2.1 , HB: 15

10/09/2025: GASES ARTERIALES: PH: 7.38 , PCO2: 33 , PO2: 58 , HCO3: 20 , PAFI : 223 , SAT: 89%, LAC ,2.5 , BE : - 5 , HB : 15 // EQUILIBRIO ACIDO BASE, DSIFUNCION PULMONAR MODERADA CON HIPERLACTATEMIA EN MEJORIA A PUNTO E LA NORMALIZACION

09/09/2025 HEMOGRAMA LEU: 26.1 NEU : 93.2 LINF: 2.9 HG : 15.9 HCTO: 49.3 PLA: 250 CR: 0.79 BUN : 19.2 NA : 140 K: 4.85 CL : 103.4 MG : 1.8 TGO: 24.9 TGP: 17.8 BT: 0.7 BD : 0.3 BI : 0.4

10/09/2025 HEMOGRAMA LEU : 21.4 NEU : 90, LINF : 4.3 HG : 15.7 HCTO: 48, PLA: 166000 CREATININA : 1.3 BUN :31 NA: 142 K : 4.08 CL : 107 MG : 2.4, CA:8, P: 4, TGO: 20. TGP: 30, TROPONINA: 0.9, PCR: 41, PT: 12, INR 1.15, PTT: 37, FIBRINOGENO: 147, TGC: 346, FERRITINA: MAYOR A 1500

-**NOREPINEFRINA** INFUSIÓN CONTINUA TITULABLE 0.05 -2.0 MCG/KG/MIN
- **PROPOFOL** INFUSION CONTINUA TITULABLE DE 1 - 4 MG/KG/HORA **PARA RASS -4** BIS 30-40
- **FENTANILO** INFUSIÓN CONTINUA TITULABLE 1-3 MCG/KG/HORA **PARA RASS -4** BIS 30-40
- **CISATRACURIO** INFUSIÓN CONTINUA A 1 A 2 MCG/KG/MIN
-**VMI P**RONO MODO APRV VT: 6.5 ML/KG, PHIGH 28 PLOW 0 THIGH 4 TLOW 1.2 FIO2 50%

- DIPIRONA 2 GR IV SI FIEBRE PERSISTENTE
-BOLO DE 500 CC DE LACTATO DE RINGER A 4 GRADOS POR SONDA OROGASTRICA PARA MANEJO DE TEMPERATURA

HIPERTERMIAS

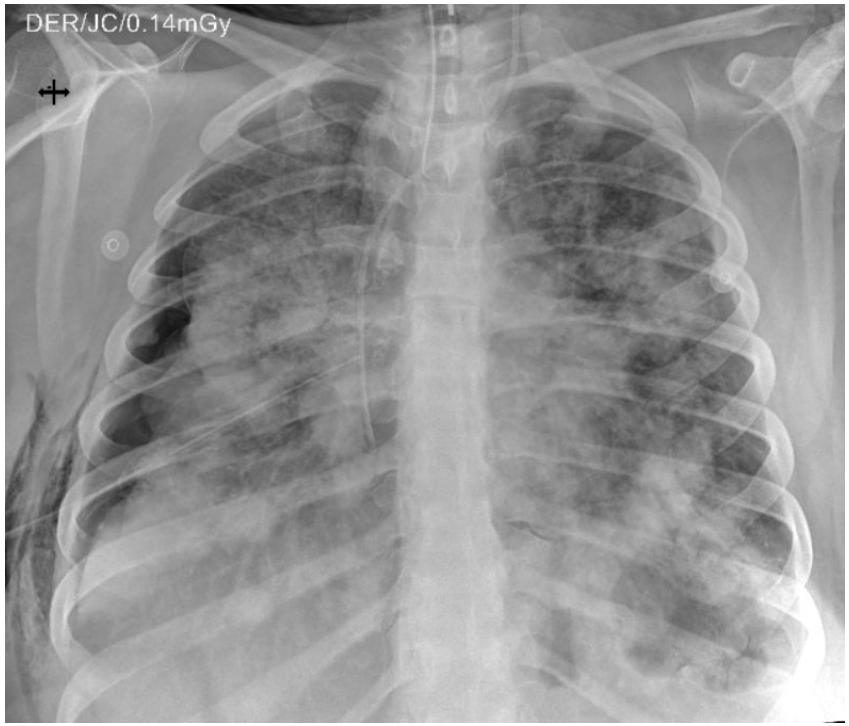
NOTA RETROSPECTIVA 10/09/2025

PACIENTE QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA POR UN SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO SEVERO CON HIPOXEMIA REFRACTARIA ACTUALMENTE EN VENTILACIONES DE CÚBITO PRONO COMO ACOPLE DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA HA REQUERIDO LA UTILIZACIÓN DE PROPOFOL Y FENTANILO PARA SEDACIÓN PROFUNDA E INFUSIÓN DE CISATRACURIO COMO RELAJANTE MUSCULAR, LA FUNCIÓN PULMONAR NO MUESTRA CAMBIOS A UN REQUIRIENTE DE VENTILACIÓN EN PRONO A NIVEL CARDIOVASCULAR HAY UN DISCRETO AUMENTO EN EL REQUERIMIENTO DEL SOPORTE VASOPRESOR DURANTE LA TARDE DE HOY, LLAMA FUERTEMENTE LA ATENCIÓN QUE DURANTE LAS 11 HORAS DEL DÍA DE HOY LA PACIENTE HA PRESENTADO CIFRAS DE FIEBRE ENTRE 38 Y 38.8 PESE A LA ADMINISTRACIÓN DE PARACETAMOL ENDOVENOSO, DIPIRONA Y MEDIOS FÍSICOS DE FORMA EXHAUSTIVA ASÍ COMO LA ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS FRÍOS POR SONDA NASOGÁSTRICA Y SONDA VESICAL NO SE HA LOGRADO EL CONTROL DE LA MISMA TENIENDO EN CUENTA ESTO SE DECIDE SUSPENDER LA INFUSIÓN DE CISATRACURIO Y SOLICITAR DE FORMA URGENTE LA REALIZACIÓN DE UNA CREATINA FOSFOQUINASA ANTE LA SOSPECHA DE UNA HIPERTERMIA MALIGNA SE SOLICITA EL PROCESAMIENTO URGENTE DE LA MUESTRA PARA EN CASO TAL DE SER REQUERIDO ACTIVAR EL PROTOCOLO HIPERTERMIA MALIGNA

Hallazgo clínico	Manifestación
Acidosis respiratoria	ET CO_2 > 55 mmHg; $PaCO_2$ > 60 mmHg
Cardíaco	Taquicardia sinusal inexplicable, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular
Acidosis metabólica	Déficit de base > 8 m/EqL o pH < 7.25
Rigidez muscular	Rigidez generalizada; rigidez severa del músculo masetero
Degradación muscular	Creatincinasa sérica concentración > 20.000 unidades/L Orina color obscuro Mioglobina urinaria o sérica K+ > 6 mEq/L
Temperatura	Incremento rápido de la temperatura > 38.8 °C
Otros	Reversión rápida de los signos de HM con la administración de dantroleno Elevación de la concentración de creatincinasa en reposo
Historia familiar	Antecedentes por herencia autosómica dominante

CPK TOTAL (CREATIN KINASA TOTAL) 645.8 U/L 5.0 170.0

NO CUMPLE CRITERIOS DE HIPERTERMIA MALIGNA



Focos de consolidación difuso en ambos campos pulmonares. Neumotórax derecho con una distancia interpleural a nivel del hilio pulmonar de 23 mm. Silueta cardiaca no valorable por interposición de densidades. Obliteración de los senos costofrénicos de forma bilateral. Catéter venoso central de acceso yugular izquierdo. Tubo orotraqueal localizado a 35 mm de la carina. Tubo de toracostomía con extremo distal proyectado en zona basal del hemitórax derecho.

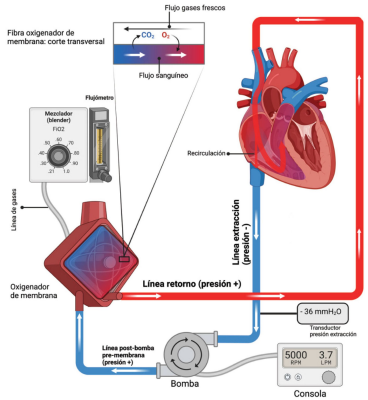
10/09/2025: GASES ARTERIALES: PH: 7.38 , PCO2: 33 , PO2: 58 , HCO3: 20 , PAFI : 223 , SAT: 89%, LAC ,2.5 , BE : - 5 , HB : 15

TERAPIA ECMO

La ECMO en el embarazo (oxigenación por membrana extracorpórea) es un soporte vital avanzado que se usa cuando el corazón y/o los pulmones de la madre gravemente enferma no funcionan adecuadamente y no responden a otras terapias

INDICACIONES:

- Insuficiencia respiratoria aguda
- Shock cardiogénico
- Paro cardiaco materno
- Shock anafiláctico o séptico con daño miocárdico significativo depresión que no responde a la terapia médica máxima
- La acidosis o la disfunción multiorgánica continúan a pesar de una reanimación agresiva



¿Cómo funciona el sistema ECMO?

- **Extracción de sangre:** Se introduce una o más cánulas (tubos) en las arterias o venas del paciente, a menudo en el cuello o la ingle.
- **Bombeo y oxigenación:** La sangre sale del cuerpo y se bombea a través de la máquina ECMO.
- **Cambio de gases:** Dentro de la máquina, un "pulmón de membrana" elimina el CO2 de la sangre y le añade oxígeno, como lo haría un pulmón sano.
- **Regreso al cuerpo:** La sangre ahora oxigenada se calienta a la temperatura corporal y se devuelve al cuerpo a través de otra cánula.

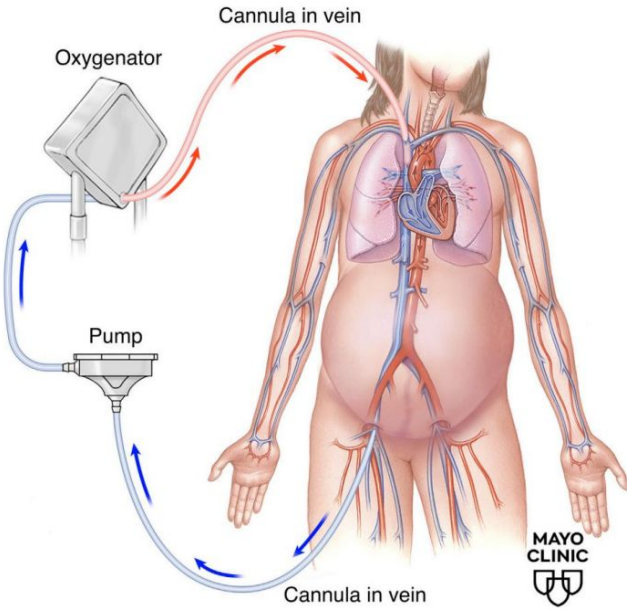
TERAPIA ECMO

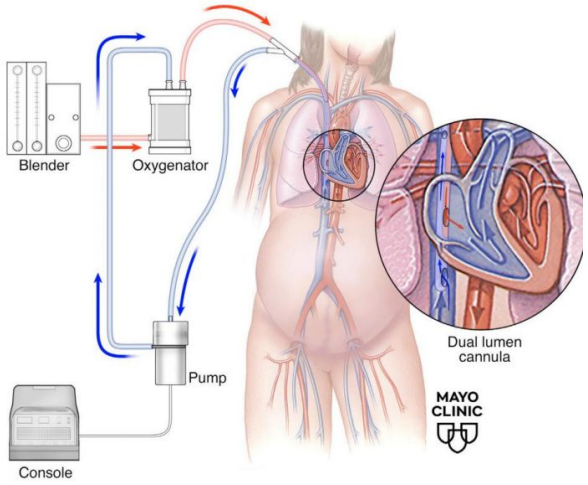
ECMO venoarterial (VA)

- **Función:** Proporciona soporte tanto al corazón como a los pulmones.
- **Indicación:** Se utiliza en casos de insuficiencia cardíaca grave o cardiorrespiratoria.
- **Mecanismo:** La sangre se extrae de una vena, se oxigena y se reintroduce directamente en una arteria, lo que bypassa la función del corazón.

ECMO venovenosa (VV)

- **Función:** Proporciona soporte exclusivamente a los pulmones.
- **Indicación:** Se emplea cuando la insuficiencia es puramente respiratoria, como en el síndrome de dificultad respiratoria grave.
- **Mecanismo:** La sangre se extrae de una vena, se oxigena y se devuelve a una vena, regresando al corazón para mones.





TERAPIA ECMO

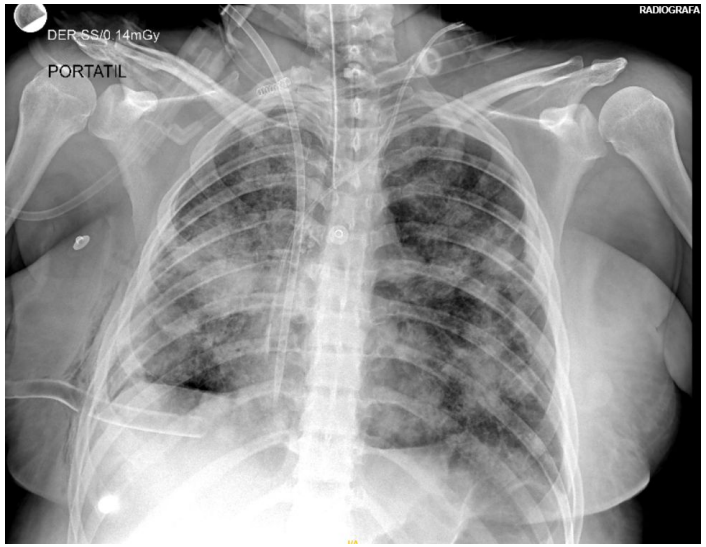
Table 1
Physiologic parameters in nonpregnant and pregnant states: Implications for ECMO management

System	Parameter	Normal nonpregnant value	Normal pregnant value	Relevance to ECMO in pregnancy
Respiratory	pH	7.35-7.45	7.40-7.45	Target higher pH and lower $PaCO_2$ in pregnancy by adjusting sweep gas flow on ECMO.
	$PaCO_2$	35-45 mmHg	28-32 mmHg	
	PaO_2	80-100 mmHg	100-110 mmHg	Adjust FdO_2 and blood flow rate for higher PaO_2 and oxygen delivery (respectively) to meet increased pregnancy demands.
	HCO_3^-	22-26 mEq/L	18-21 mEq/L	Reduced bicarbonate limits buffering capacity, important in managing metabolic acidosis on ECMO.
Hematologic	Clotting factors	Normal adult reference ranges	Elevated (factors I, VII, VIII, IX, X, and XII)	Hypercoagulable state increases thrombosis risk; anticoagulation must be carefully managed during ECMO.
	Platelet aggregation	Normal	Increased	Enhanced platelet activity further elevates clotting risk; balancing anticoagulation is critical.
Cardiovascular	Cardiac output	4-6 L/min	6-9 L/min (↑30%-50%)	Increased baseline cardiac output and plasma volume during pregnancy necessitate higher ECMO flow rates to ensure adequate maternal–fetal perfusion.
	Plasma volume	~5 L	↑40%-50% plasma volume	
	Heart rate	60-100 bpm	80-100 bpm	Higher heart rate is common in pregnancy; ECMO providers should recognize this as a normal compensatory adaptation.
Renal	Serum creatinine	0.6-1.1 mg/dL	Often <0.7 mg/dL	Lower baseline creatinine can mask early kidney injury; vigilant renal monitoring is vital during ECMO. AKI thresholds differ during pregnancy, which may affect the timing of CRRT initiation.
	GFR	~90-120 mL/min	↑40%-50% (up to 150-180 mL/min)	Increased GFR alters drug clearance and fluid balance; dosing adjustments and close monitoring are needed during ECMO.
Mechanical	Aortocaval compression	None	Present after 20 weeks gestation	Aortocaval compression can affect cannulation (femoral VA or VV-ECMO) and ECMO flows during support. Left lateral positioning or manual uterine displacement is recommended during ECMO initiation and maintenance.

EVOLUCIÓN DIA 11/09/2025

11/09/2025 GASES VENOSOS PH: 7.21 , PCO2: 64, PO2: 40 , HCO3: 26 , SAT: 63%, LAC 1.5 , BE : -1.7, HB : 15 // T. EXTRACCION DE 29 DELTA DE CO2 EN 16
11/09/2025 GASES ARTERIALES PH: 7.28 , PCO2: 48, PO2: 65 , HCO3: 23 , PAFI : 185, SAT: 89%, LAC 1.6 , BE : -3.9, HB : 15 // ACIDOSIS METABOLICA CON DSIFUNCION PULMONAR SEVERA SIN HIPERLACTATEMIA.

11/09/2025 GASES ARTERIALES PH: 7.32 , PCO2: 41, PO2: 70 , HCO3: 21 , PAFI : 200, SAT: 92%, LAC 1.6 , BE : -4.5, HB : 15 // ACIDOSIS METABOLICA CON DSIFUNCION PULMONAR SEVERA SIN HIPERLACTATEMIA.
11/09/2025 GASES ARTERIALES PH: 7.29 , PCO2: 43, PO2: 69 , HCO3: 21 , PAFI : 230, SAT: 91%, LAC 1.5 , BE : -4.2, HB : 15 // ACIDOSIS METABOLICA CON DSIFUNCION PULMONAR SEVERA SIN HIPERLACTATEMIA**.**
11/09/2025 GASES ARTERIALES PH: 7.32 , PCO2: 39, PO2: 76.8 , HCO3: 20 , PAFI : 219, SAT: 94%, LAC ,1.7 , BE : -



3 ciclos de prono

AUMENTO DE SOPORTE VASOPRESOR vasopresina

- FIEBRE INTRATABLE

- FIEBRE NO CONTROLADA A PESAR DE MANEJO CON ANTIPIRÉTICOS, MEDIOS FÍSICOS Y LÍQUIDOS FRÍOS
- PARACLÍNICOS MUESTRAN LEUCOCITOSIS PERSISTENTE CON NEUTROFILIA MARCADA, TROMBOCITOPENIA PROGRESIVA (93.000 – 122.000
- PROTEÍNA C REACTIVA Y FERRITINA MARCADAMENTE ELEVADAS, DÍMERO D AUMENTADO, LO QUE SUGIERE UN ESTADO INFLAMATORIO SISTÉMICO SEVERO CON DISFUNCIÓN MULTIORGÁNICA INCIPIENTE.
- SUMA INJURIA RENAL AGUDA ESTADIO AKIN I (CREATININA ESTABLE 1.29–1.3, BUN 31–49),
- ACIDOSIS METABÓLICA CON COMPENSACIÓN PARCIAL, SIN HIPERLACTATEMIA SIGNIFICATIVA, PERO EN RELACIÓN CON DISFUNCIÓN PULMONAR GRAVE.
- CANDIDATA A ESTRATEGIAS DE SOPORTE EXTRACORPÓREO RENAL MEDIANTE HEMODIAFILTRACIÓN, NO SOLO COMO MEDIDA DEPURATIVA, SINO TAMBIÉN COMO TERAPIA DE CONTROL DE LA TORMENTA INFLAMATORIA, CON EL FIN DE MODULAR LA RESPUESTA SISTÉMICA.

PACIENTE MOTEADA BAJO VENTILACIÓN MECÁNICA EN PRONO.
RUIDOS RESPIRATORIOS HIPOVENTILACIÓN GLOBAL LLENADO CAPILAR LENTO

NOTA RETROSPECTIVA 12/09/2025 (4+30 AM)

- PH 7.14 HCO3 DE 17.7 POTASIO 7.0 POR GASES SERICO 5.5, SE INDICA GLUCONATO DE CALCIO DADO TAQUICARDIA DE COMPLEJO ANCHO INTERPRETADA COMO TAQUICARDIA VENTRICULAR MONOMÓRFICA EN PACIENTE MULTI SOPORTADA SE CONSIDERA MANEJO CON CARDIOVERSIÓN ELECTRICA

- SE INICIA ALBUMINA DADO ESTADO DE CHOQUE, EN EL MOMENTO EN PRONO POR LO CUAL SE SUPINA PARA CARDIOVERSIÓN SE DISMINUYE SEDACIÓN.
- MUY MAL ESTADO GENERAL DURANTE LA NOCHE CON FIEBRE INTRATABLE SE ADMINISTRÓ DIPIRONA, PARACETAMOL, LIQUIDOS FRIOS PERIFERICOS, CON POR SONDA OROGÁSTRICA POR SONDA VESICAL CON MEDIOS FISICOS DE FORMA PERIFÉRICA CON TEMPERATURA DE 40.6 GRADOS
- LA TAQUICARDIA Y TODA LA CASCADA INFLAMATORIA PRESENTADA ESTE LLEVANDO A CHOQUE
- HEMODIAFILTRACION URGENTE SE REALIZA AJUSTE DE PARAMETROS POR PARTE DE NEFROLOGIA PARA UNICAMENTE REALIZAR LA DIALISIS Y NO ULTRAFILTRAR
- VASOPRESOR A DOSIS ALTA
- HIPOXEMIA CON FIEBRE PERSISTENTE, CON CHOQUE REFRACTARIO, SIN DISPONIBILIDAD DE VASOPRESINA COMO SEGUNDO VASOPRESOR POR DESABASTECIMIENTO NACIONAL
- ALTO RIESGO DE MORTALIDAD A CORTO PLAZO, SE CONSIGUE UNA UNICA AMPOLLA DE VASOPRESINA EN LA INSTITUCIÓN CV SE INICIA 4 UNIDADES HORA
- BRONCOESPASMO POR LO CUAL SE INDICA BETA 2 INHALADO TIENE INFUSIÓN DE ESTEROIDE Y SE INICIA ADMINISTRACIÓN DE SULFATO DE MAGNESIO 2 GR EN PRO DE MEJORAR EL BRONCOESPASMO
- EPINEFRINA
- SUSPENDEN DIÁLISIS DADO ESTADO DE CHOQUE REFRACTARIO
- DESCENSO DE TEMPERATURA 38.2 GRADOS
- SE INICIÓ UN TERCER VASOPRESOR MEJORANDO PRESIÓN ARTERIAL

NOTA RETROSPECTIVA 12/09/2025 (5+00 AM)

PACIENTE CON TAQUICARDIA DE COMPLEJO ANCHO INESTABLE DADO MULTIPLES VASOPRESORES, SE PROCEDE A REALIZAR CARDIOVERSIÓN SINCRONIZADA CON MEJORIA DE TAQUICARDIA Y DE COMPLEJO ESTRECHO AHORA, SE SUSPENDIÓ LA EPINEFRINA EN PRO DE MEJORAR TAQUICARDIA SIN EMBARGO DE NUEVO PRESENTA HIPOTENSIÓN RAZÓN POR LA CUAL SE INICIA INFUSIÓN A LA MITAD DE LA DOSIS INICIAL, PACIENTE CON LABILIDAD HEMODINÁMICA SEVERA TRI SOPORTADA, SE SUSPENDIO HEMODIALISIS, CONTINUA MOTEADA ACIDEMIA RESPIRATORIA REFRACTARIA SE INDICA REMISION ECMO VENOARTERIAL.



SE REALIZA ORDEN DE AMBULANCIA PARA TRANSPORTE AEREO YA QUE POR INESTABILIDAD DE LA PACIENTE REQUIERE TRASLADO URGENTE

EVOLUCIÓN DIA 12/09/2025 (2+00 PM)

PACIENTE FEMENINA DE 27 AÑOS CON DIAGNÓSTICOS DE:
- CHOQUE REFRACTARIO
-SÍNDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO SEVERO DEL ADULTO
- NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD PSI SCORE Clase V (riesgo alto)
- INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA - POP TORACOSTOMÍA CERRADA DERECHA 09/09/2025
- NEUMOTÓRAX DERECHO
- POSTOPERATORIO CESÁREA 08/09/2025 G2C1P1V2
- RECIÉN NACIDO MASCULINO APGAR 3-4-8
- PUERPERIO MEDIATO - INJURIA RENAL AGUDA AKIN I
- INJURIA MIOCÁRDICA ASOCIADA A LA SEPSIS
- ASMA PERSISTENTE MODERADA/GRAVE
- CRISIS ASMATICA SEVERA
- RIESGO OBSTÉTRICO ALTO MADRE CON DIAGNÓSTICO DE THAE RIESGO ISOINMUNIZAIÓN RH NEGATIVO
RIESGO TROMBOEMBOLICO BAJO RIESGO PSICOSOCIAL: BAJO ESCALA HERRERA Y HURTADO DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL: SOBREPESO PARA EDAD GESTACINOAL ATHALA IMC 30

BALANCE HÍDRICO 24 HORAS
ADMINISTRADOS: 5321 CC
- ELIMINADOS: 2100 CC
GASTO URINARIO: 1.0 CC/KG/HORA
BALANCE: (+) 3321 CC

12/09/2025 LEUCOS **:** 24.39 NEU : 93.5 LINF : 2.7 HG : 15.7 HCTO: 49.2 PLA : 76. 000 PLAQUETAS MANUAL : 72.000 CR: 1.42 BUN : 62.5 NA : 143 K : 5.56 CL : 107 MG : 3.2 CA: 1.22 TSH : 0.06 T4L: 1.02 POTASIO 7.0 MAGNESIO 3.9 CALCIO 7.8

12/09/2025 TAQUICARDIA REGULAR DE COMPLEJO ANCHO

12/09/2025GASES ARTERIALES HORA 10+00 PH 6.7 PCO2 51.4 PO2 95 HCO3 6.4 LACTATO 12.7 PAFI 95 SATURACION 82% 12/09/2025 GASES ARTERIALES

04+15 AM: PH 7.14 PCO2 50.8 PO2 76.3 HCO3 17.7 BE -11.4 PAFI 76.3 GASES ARTERIALES 06+50 AM PH 6.90 CO2 40.5 PO2 112.6 LACTATO 7.7 PAFI 112 BASE EXCESO -24.8

EVOLUCIÓN DIA 12/09/2025 (2+00 PM)

JESSIKA PACIENTE EN CUIDADO INTENSIVO DESDE EL 08/09/2025 EN CONTEXTO DE UNA CRISIS ASMATICA SEVERA CON NECESIDAD DE VENTILACION MECANICA CON CRITERIOS PARA SINDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO AGUDO CON TRANSTORNO SEVERO DE LA OXIGENACION QUIEN EN LAS ULTIMAS 24 HORAS HA PRESENTADO UN DETERIORO DE SU ESTADO SEVERO AL PUNTO DE REQUERIR TRES MEDICAMENTOS DIFERENTES VASOPRESORES EN LAS ULTIMAS 8 HORAS CON NECESIDAD DE BOLOS DE BICARBONATO EN ARAS DE MEJORAR ACIDEMIA Y ASI MEJORAR LA ACTUACION DE LOS VASOPRESORES, SE USO TIAMINA, TERLIPRESINA DADO NO DISPONIBILIDAD DE VASOPRESINA COMO MANEJO DEL CHOQUE REFRACTARIO, DURANTE LA MAÑANA DURANTE VARIAS OCASIONES PRESENTO TENSION ARTERIAL SISTOLICA POR DEBAJO DE 70 MMHG QUE MEJORARON INICIALMENTE CON BOLO DE AZUL DE METILENO PERO NO CON INFUSION CONTINUA, CON BOLO DE BICARBONATO PERO NO CON LA INFUSION DE BICARBONATO, DE DIAGNOSTICOS DE TRABAJO SE PLANTEO UN SDRA SECUNDARIO A INFECCION VIRAL CON POSTERIOR COMPROMISO MULTIORGANICO Y CHOQUE SEPTICO REFRACTARIO Y ESTABAMOS A LA ESPERA DE AISLAMIENTOS POR HEMOCULTIVOS LOS CUALES HASTA EL MOMENTO VAN NEGATIVOS, EN PROCURA DE MEJORAR PARAMETROS DE CHOQUE SE SUSPENDIO PROPOFOL SIN RESPUESTA A ESTA MANIOBRA CON UN EMPEORAMIENTO GASIMETRICO SEVERO EN LOS GASES ARTERIALES CONTROL DE LA MAÑANA 10 AM PH 6.7 HCO3 6 LACTATO DE 12, ADEMAS PACIENTE ANURICA Y CON EMPEORAMIENTO DEL MOTEADO, CONSIDERANDO CURSA CON UN CHOQUE REFRACTARIO Y PROBABLEMENTE EN FASE NO REVERSIBLE SE INDICA SUPINAR LA PACIENTE PREVINIENDO UNA PARADA CARDIACA EN PRONO ALREDEDOR DE LAS 09+00 AM, A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA SE REALIZA COMUNICACION CON EPS COOSALUD CRUEB BOYACA Y SE ENVIA FORMATO DE REMISION A ESTAS ENTIDADES SOLICITANDO TERAPIA ECMO, DURANTE LA NOCHE SE PLANTEARON CRITERIOS PARA ECMO QUE NO CUMPLIA LA PACIENTE PARA ESTA TERAPIA NO TENIA UNA PAFI MENOR DE 80 NO EL PH ERA DE 7.25 SIN EMBARGO EL CO2 DE 56, COMO CONSTATA EN ANTERIORES EVOLUCIONES SE REALIZO INICIO DE HEMODIAFILTRACION EN PRO DE BARRER MEDIADORES INFLAMATORIOS Y LOGRAR DISMINUIR LA RESPUESTA SISTEMICA Y LA FIEBRE INTRATABLE, SIN EMBARGO CON NECESIDAD DE AUMENTAR EL SOPORTE SE DECIDIÓ SUSPENDER DICHA TERAPIA Y DURANTE LA EVOLUCION

EL CHOQUE REFRACTARIO INICIA A LAS 05+20 AM DONDE SE INICIA ADRENALINA Y VASOPRESINA UNICA AMPOLLA DISPONIBLE POR DESABASTECIMIENTO NACIONAL DE DICHO MEDICAMENTO SE PLANTEO LA NECESIDAD DE ECMO SOLICITUD QUE QUEDO RADICADA EN LA MAÑANA CON GRAN AYUDA DE EPS COOSALUD QUIEN NOS ENVIO DOS ACEPTACIONES DE LA PACIENTE INICIALMENTE FUNDACION CARDIO INFANTIL QUE NO PODIA REALIZAR EL TRASLADO PARA CANULAR LA PACIENTE Y CLINICA SAN LUIS BUCARAMANGA QUE TENIA EL EQUIPO DE ESPECIALISTAS LISTOS PARA TRASLADO SIN EMBARGO POR UBICACION GEOGRAFICA NO EXISTIA UNA PISTA ADECUADA CERCANA A NUESTRO HOSPITAL PARA REALIZAR CANULACION Y POSTERIOR TRASLADO, INFORMACION SUMINISTRADA POR GESTORA PARA BOYACA DE EPS COOSALUD CONTINUANDO CON EL ESTADO DE LA PACIENTE JESSIKA YA HABIA TENIDO ESTUDIOS DE DERRAME PLEURAL EN PRO DE DESCARTAR EMPIEMA NEGATIVO PARA ESTA POSIBILIDAD EL ESTUDIO DEL LIQUIDO PLEURAL, HABIA TENIDO ESTUDIOS DE INFECCION DE VIAS URINARIAS, TORMENTA TIROIDEA ENTRE OTRAS PATOLOGIAS QUE FAVORECIERAN EL ESTADO INFLAMATORIO SIN

EVOLUCIÓN DIA 12/09/2025 (2+00 PM)

EMBARGO DICHAS PATOLOGÍAS FUERON DESCARTADAS, LA EVOLUCION RADIOGRAFICA Y LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS NOS HIZO PENSAR SIEMPRE EN UN SÍNDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO AGUDO CON TRANSTORNO SEVERO DE LA OXIGENACIÓN FAVORECIDO POR SU ESTADO ASMATICO SIENDO LAS 11+00 AM PACIENTE PRESENTA TAQUICARDIA DE COMPLEJO ESTRECHO SUPRAVENTRICULAR EN UNA PACIENTE INESTABLE REQUIRIENDO DE CARDIOVERSIÓN SINCRONIZADA CON 80 JULS MEJORANDO LA TAQUICARDIA, SIENDO LAS 12+31 PM Y TRAS UN CHOQUE REFRACTARIO UNA VASOPLEJIA SEVERA UN DISTRESS RESPIRATORIO SEVERO REFRACTARIO CON INFUSIÓN DE NOREPINEFRINA A 2 MCG KG MIN 1.5 MCG KG MIN Y AZUL DE METILENO A 2 MG K HORA LA PACIENTE PRESENTA UNA PARADA CARDIACA RITMO DE PARO ACTIVIDAD ELECTRICA SIN PULSO SE INICIAN MANIOBRAS DE REANIMACIÓN AVANZADA COMPRESIONES VENTILACIONES SE REALIZA CORRECCION DE HIPERKALEMIA Y HIPERMAGNESEMIA CON GLUCONATO DE CALCIO, ADMINISTRACION DE ADRENALINA CADA 3 MINUTOS SEGUN PROTOCOLO AHA CON COMPROBACION DE RITMO Y PULSO CADA DOS MINUTOS PERSISTIENDO DURANTE 21 MINUTOS EN ASISTOLIA, SE ADMINISTRAN 8 AMPOLLAS DE EPINEFRINA DURANTE LA REANIMACIÓN Y TRAS 21 MINUTOS DE PARADA CARDIACA EN RITMO DE ASISTOLIA Y NO OBTENER RETORNO A CIRCULACIÓN ESPONTÁNEA SE PARAN ESFUERZOS DE REANIMACIÓN Y SE DECLARA FALLECIDO

12+52 PM SE REALIZA INFORMACIÓN A LA FAMILIA DEL DESENLACE FATAL SE LES PRESTA ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO SE PERMITE DESCARGA EMOCIONAL E INGRESAN FAMILIARES A CUBÍCULO DE UCI, POR PARTE DE SECRETARIA DE SALUD SUGIEREN REALIZAR NECROPSIA CLÍNICA DADO QUE ES UN EVENTO DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA Y AL SOLICITAR AUTORIZACIÓN A LA FAMILIA MADRE Y ESPOSO DE LA PACIENTE NO AUTORIZAN REALIZACIÓN DE LA MISMA POR LO CUAL SE PROCEDE A CERRAR HISTORIA CLÍNICA REALIZAR CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN Y EPICRISIS

Gracias

HOSPITAL REGIONAL de MONIQUIRÁ E.S.E

Crecemos para cuidar tu Salud!

ANA MARITZA DÁVILA BARÓN

GERENTE